



Institut für
Internationale Gesundheit

Charité Center
for Global Health

Update Impfen – mit Relevanz für bakterielle Infektion und Antibiotikaeinsatz

Andreas Lindner | ABS *fellow* Berlin, 02. Juni 2026

Eine Frage an Sie:

**„Ist Impfen in Ihrem Arbeitsalltag
ein praktisch relevantes Thema?“**

- A) Ja, regelmäßig
- B) Ja, gelegentlich
- C) Ja, selten
- D) Nein

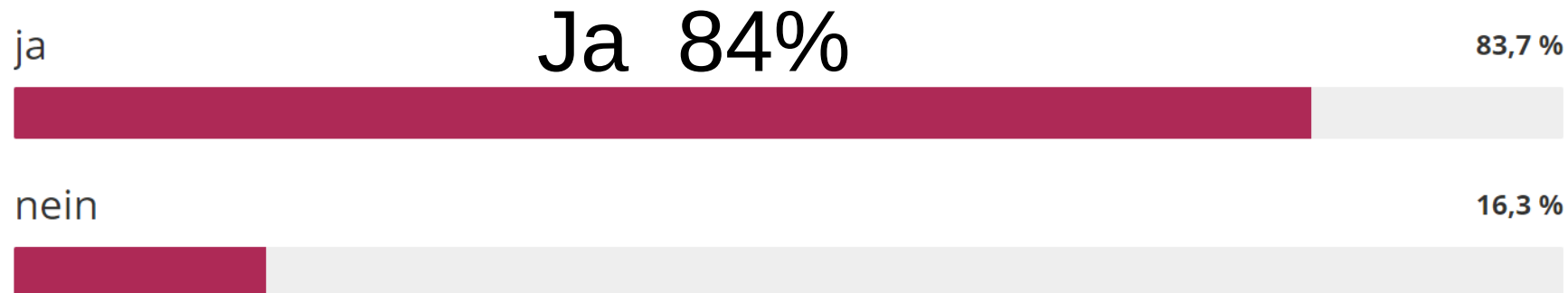
Befragung Hausärzt:innen:

„Wünschen Sie sich
mehr Initiative anderer Fachkolleg:innen
im Bezug auf Impfungen?“



43

...



Impfen über alle Alters- und Fachgrenzen möglich und erwünscht

(IFSG § 20, Abs. 4.)

„(4) Zur Durchführung von Schutzimpfungen ist jeder Arzt berechtigt. Fachärzte dürfen Schutzimpfungen unabhängig von den Grenzen der Ausübung ihrer fachärztlichen Tätigkeit durchführen.“

Vaccine hesitancy



World Health
Organization



World Health
Organization

Health Topics ▾

Countries ▾

News ▾

Emergencies ▾



**Ten threats
to global health in 2019**

STIKO@rki: Alles in einer App

Die **interaktive** Fassung der Impfeempfehlungen und weitere hilfreiche Informationen rund ums Impfen finden Sie hier...



Hier erhältlich:



OS		
	§	Infoseite
es schehen	STIKO-Empfehlungen 2026	Impfkalender 2026
material	Erklärfilme	STIKO-Empfehlungen interaktiv
tionelle xe	Fachinfos	Lieferengpässe

www.stiko-web-app.de/


Impf-Infos








Infoseite

 Impf-News	 Wissens-Check	 Aktuelles Infektionsgeschehen	 STIKO-Empfehlungen 2026	 Impfkalender 2026
 FAQs	 RKI-Ratgeber	 Informationsmaterial	 Erklärfilme	 STIKO-Empfehlungen interaktiv
 Reiseimpfungen	 Indikationsimpfungen für Risikogruppen	 Postexpositionelle Prophylaxe	 Fachinfos	 Lieferengpässe

Impf-Infos



> Indikationsimpfungen für **Risikogruppen**

Klinische Situation

Auswahl

Risiko

Risikogruppe

Gesundheitliche Risiken

Art des Risikos

Immundefizienz bzw. -suppression (I)

Erreger (Links führen zu detaillierten Informationen in den STIKO Impfempfehlungen)

- [Hepatitis B](#)
- [Herpes zoster](#)
- [Influenza](#)
- [Meningokokken](#)
- [Pneumokokken](#)
- [SARS-CoV-2](#)
- [Varizellen](#)

1. Vorbemerkung	6	5.2 Impfungen bei gehäuftem Auftreten oder Ausbrüchen von Meningokokken- Erkrankungen	53
2. Impfkalender	7	5.3 Postexpositionelle Hepatitis-B- Immunprophylaxe	56
3. Standardimpfungen des Erwachsenenalters, Indikations- und Auffrischimpfungen sowie Impfungen aufgrund eines erhöhten beruflichen Risikos oder einer Reise	9	5.4 Postexpositionelle Tetanus- Immunprophylaxe	58
3.1 Übersicht	9	5.5 Postexpositionelle Tollwut- Immunprophylaxe	58
3.2 Anmerkungen zu einzelnen Impfungen	19		
4. Hinweise zur Durchführung von Schutzimpfungen	35	6. Empfehlungen zu Nachholimpfungen	60
4.1 Aufklärungspflicht vor Schutzimpfungen ..	35	6.1 Vorbemerkung	60
4.2 Off-label-use	37	6.2 Ungeimpfte und Personen mit unklarem Impfstatus	61
4.3 Dokumentation der Impfung	38	6.3 Teilgeimpfte Personen	61
4.4 Impfmanagement	38	6.4 Vorgehen bei fehlender Impfdokumentation	61
4.5 Impfabstände	40	6.5 Anamnestic Angaben zu Varizellen	61
4.6 Hinweise zur Schmerz- und Stressreduktion beim Impfen	41	6.6 Indikation für serologische Antikörper- bestimmungen	62
4.7 Kontraindikationen und falsche Kontraindikationen	42	6.7 Ist „Überimpfen“ gefährlich?	62
4.8 Impfungen zum Schutz der reproduktiven Gesundheit, bei Kinderwunsch und während Schwangerschaft und Stillzeit	44	6.8 Wahl der Impfstoffe	62
4.9 Impfen bei Immundefizienz	46	6.9 Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Poliomyelitis und Pertussis ab dem Alter von 5 Jahren	63
4.10 Impfreaktionen, Impfkomplicationen sowie Impfschäden und deren Meldung ...	46	6.10 Altersabhängige Empfehlungen zur Durchführung von Nachholimpfungen	63
4.11 Impfungen von Personal in medizinischen Einrichtungen	48		
4.12 Impfempfehlungen für Migrantinnen und Migranten und Asylsuchende nach Ankunft in Deutschland	48	Liste der STIKO-Empfehlungen und ihrer wissenschaftlichen Begründungen	73
4.13 Lieferengpässe von Impfstoffen	50	STIKO-App	77
4.14 Hinweise zur Kostenübernahme von Schutzimpfungen	52	Weitere Informationsmaterialien	78
5. Postexpositionelle Impfungen bzw. andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten	52		
5.1 Übersicht	52		



4 Epidemiologisches Bulletin

22. Januar 2026

Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission beim Robert Koch-Institut 2026



Faktenblätter alphabetisch sortiert zum Download

↓ [COVID-19-Impfung](#)

PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei

↓ [FSME-Impfung](#)

PDF, 859 KB, Datei ist nicht barrierefrei

↓ [HPV-Impfung](#)

PDF, 986 KB, Datei ist nicht barrierefrei

↓ [Influenza-Impfung](#)

PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei

↓ [Meningokokken-Impfung](#)

PDF, 170 KB, Datei ist nicht barrierefrei

↓ [RSV-Impfung für ältere Menschen](#)

PDF, 146 KB, Datei ist nicht barrierefrei

↓ [Falsche und richtige Kontraindikationen bei Impfungen](#)

PDF, 573 KB, Datei ist nicht barrierefrei

↓ [Herpes-zoster-Impfung](#)

PDF, 933 KB, Datei ist nicht barrierefrei

↓ [Impfungen in der Schwangerschaft](#)

PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei

↓ [Masern-Impfung](#)

PDF, 220 KB, Datei ist nicht barrierefrei

↓ [Pneumokokken-Impfung](#)

PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei

↓ [RSV-Prophylaxe](#)

PDF, 597 KB, Datei ist nicht barrierefrei



Impfungen in der Schwangerschaft

Schwerpunkt Pertussis (Keuchhusten)



Wovon und wie schützt die Pertussis-Impfung?

Risiken der Pertussis-Erkrankung



starker, atemraubender Husten, Lungenentzündung



vorzeitige Wehen



Atemaussetzer, Lungenentzündung, Tod

Schutz durch die Pertussis-Impfung

Immunität Immunglobulin-G-Antikörper



Wie hoch ist die Schutzwirkung der Impfung?

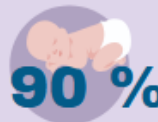
Ohne Impfung der Mutter erkranken 11 von 10.000 Säuglingen an Pertussis.



Mit Impfung der Mutter erkranken 1 von 10.000 Säuglingen an Pertussis.



Das Risiko von Säuglingen in den ersten 3 Lebensmonaten an Pertussis zu erkranken, sinkt durch eine Impfung der Mutter in der Schwangerschaft um



Für wen und wann ist die Impfung empfohlen?



Schwangere ab der 28. SSW (beste Schutzwirkung im frühen 3. Trimenon)



Bei erhöhter Wahrscheinlichkeit für eine Frühgeburt sollte die Impfung ins 2. Trimenon vorgezogen werden.



Eltern, Geschwister und Betreuende des Neugeborenen nach Möglichkeit spätestens 4 Wochen vor Geburt

- weitere Impfempfehlungen in Schwangerschaft und Stillzeit auf der Rückseite -

Pertussis (Keuchhusten) in der Schwangerschaft

1 Pertussis ist hoch ansteckend und weit verbreitet.

2 Die häufigsten, schweren Komplikationen treten bei Neugeborenen auf, die noch nicht geimpft werden können.

3 Eine Pertussis-Impfung der Mutter kann bei Säuglingen in den ersten Lebensmonaten Infektionen, Krankenhauseinweisungen und Todesfälle verhindern.

4 Eine Impfung schützt Mutter und Kind.

5 Für Pertussis ist in Deutschland kein Einzelimpfstoff zugelassen. Für Schwangere stehen 3- oder 4-fach-Impfstoffe zur Verfügung.



Wie sicher ist die Pertussis-Impfung?



kein erhöhtes Risiko für Schwangerschaftskomplikationen und keine negativen Auswirkungen auf den Säugling



Lokalreaktionen, die meist folgenlos abklingen. Allgemeinsymptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Fieber



Lokalreaktionen und Allgemeinsymptome nicht häufiger als bei nicht schwangeren Frauen



Antworten auf häufig gestellte Fragen

1 Warum sollte in der Schwangerschaft geimpft werden?

Die mütterliche Immunisierung ist ein sicheres und wirksames Mittel, um Neugeborenen durch die Übertragung mütterlicher Antikörper in den ersten Lebensmonaten einen passiven Immunschutz vor Infektionen zu vermitteln. Impfungen während der Schwangerschaft schützen die werdende Mutter vor Infektionskrankheiten oder zumindest vor schweren Krankheitsverläufen, die das Risiko für Fehl- und Frühgeburten erhöhen und in seltenen Fällen zum Tod von Un- und Neugeborenen führen können.

2 Ist es unbedenklich, sich in der Schwangerschaft impfen zu lassen?

Impfungen in der Schwangerschaft mit inaktivierten Impfstoffen (Totimpfstoffe) sind sicher. Dennoch sollten im ersten Drittel der Schwangerschaft nur dringend Indizierte Impfungen durchgeführt werden, um zu vermeiden, dass die in der Frühschwangerschaft häufigen Spontanaborte mit der Impfung in Zusammenhang gebracht werden.

3 Welche Impfungen sind in der Schwangerschaft von der STIKO empfohlen?

Einige Impfungen z. B. gegen Influenza, können ohne höheres Risiko in der Schwangerschaft verabreicht werden. Es handelt sich hierbei um Totimpfstoffe, die keine Infektionen auslösen können. Frauen mit Kinderwunsch sollten bereits vor einer Schwangerschaft ihren Impfstatus überprüfen lassen, insbesondere um Impflücken bezüglich Masern, Röteln und Varizellen zu schließen, für die nur Lebendimpfstoffe zur Verfügung stehen, die nicht während der Schwangerschaft verabreicht werden können. Während der Stillzeit können grundsätzlich sowohl Tot- als auch die meisten Lebendimpfstoffe verabreicht werden. Allein die Gelbfieber-Impfung soll bei stillenden Frauen nicht erfolgen.

Optional können auch folgende Totimpfstoffe nach Risiko-Nutzen-Abwägung durchgeführt werden: Poliomyelitis (IPV-Impfstoff), Meningokokken C, Pneumokokken, HPV-Impfung (Humane Papillomviren). Hinzu kommen ggf. die Reiseimpfungen: Tollwut, Typhus (parenteraler Totimpfstoff), Japanische Enzephalitis, Meningokokken ACWY sowie FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis). Für gesunde Schwangere ist eine SARS-CoV-2-Basisimmunität ausreichend. Liegt diese nicht vor oder hat die Schwangere Grunderkrankungen, sollte die COVID-19-Impfung ab dem 2. Trimenon verabreicht werden.

4 Welche Impfungen sind in der Schwangerschaft nicht erlaubt?

Impfungen mit Lebendimpfstoffen (z. B. gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken) sind in der Schwangerschaft kontraindiziert. Eine versehentliche Lebendimpfung kurz vor oder in der Frühschwangerschaft ist jedoch keine Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch, da bisher weltweit kein erhöhtes Risiko für eine kongenitale Fehlbildung durch dokumentierte Impfungen mit Röteln-, Masern-Röteln- und MMR-Impfstoffen festgestellt wurde.



Von der STIKO empfohlene Impfungen

indiziert	möglich	kontraindiziert
Influenza (Totimpfstoff)		einmal ab 2. Trimenon*
COVID-19 (mRNA)		ab 2. Trimenon**
Pertussis mit Kombinationsimpfstoff		im 3. Trimenon***
Diphtherie		
Tetanus		nach Exposition
Polio (IPV-Impfstoff)		
Masern, Mumps, Röteln (Lebendimpfstoff)		
Windpocken (Lebendimpfstoff)		
Hepatitis B		nach Exposition

* bei Vorerkrankung (Asthma, Diabetes mellitus, Bluthochdruck) bereits im 1. Trimenon

** indiziert bei nicht vorhandener Basisimmunität oder bei Vorerkrankungen

*** bei bekanntem Frühgeburtsrisiko bereits im 2. Trimenon



Impfungen für Frauen mit Kinderwunsch

- COVID-19: Das Bestehen einer Basisimmunität sollte überprüft und ggf. vervollständigt werden.
- Masern: Nach 1970 geborene Erwachsene, die einen unklaren Impfstatus haben, bisher nicht geimpft oder nur einmal in der Kindheit geimpft wurden, erhalten eine einmalige Impfung mit einem Masern-Mumps-Röteln (MMR)-Impfstoff als Standardimpfung.
- Röteln: Ungeimpfte Frauen oder Frauen mit unklarem Impfstatus im gebärfähigen Alter erhalten einen zweimaligen MMR-Impfstoff im Abstand von vier Wochen. Frauen im gebärfähigen Alter, die bereits einmal geimpft wurden, erhalten eine weitere Dosis mit einem MMR-Impfstoff.
- Windpocken: Seronegative Frauen mit Kinderwunsch erhalten zwei Impfdosen.
- Aufgrund theoretischer Überlegungen wird generell empfohlen, nach Lebendimpfungen (Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, Gelbfieber) einen Zeitraum von mindestens einem Monat bis zu einer Schwangerschaft einzuhalten.



Public-Health-Perspektive

Schwangere, Feten und Säuglinge in den ersten Lebensmonaten sind besonders gefährdet, an Infektionskrankheiten zu erkranken oder sogar zu versterben. Impfungen vor oder während der Schwangerschaft können dieses Risiko reduzieren. Impfungen in der Schwangerschaft zielen auf den direkten Schutz der Schwangeren durch aktive Immunisierung und/oder des Kindes durch passive Immunisierung. Weitere Maßnahmen der Infektionsprävention sind die zeitgerechte Verabreichung der empfohlenen Standardimpfungen von Geburt an, die „Kokonstrategie“ (Impfung von Kontaktpersonen) sowie die zeitgerechte Gabe aller für junge Erwachsenen empfohlenen Impfungen, insbesondere bei Frauen im gebärfähigen Alter und mit Kinderwunsch.

Die vorliegende Darstellung zu Impfungen in der Schwangerschaft soll Ärztinnen und Ärzten als Kurzinformation dienen und im Gespräch mit Patientinnen und Patienten oder Sorgeberechtigten unterstützen. Für das Aufklärungsgespräch ist zu beachten, dass die Fachinformationen des jeweiligen Impfstoffs maßgeblich sind.

Weitere Informationen unter: www.rki.de/impfen

Stand: September 2021 | Gestaltung: www.infotext-berlin.de





Wie hoch ist die Schutzwirkung der Impfung?

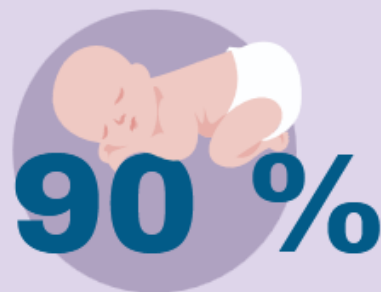
Ohne Impfung der Mutter erkranken 11 von 10.000 Säuglingen an Pertussis.



Mit Impfung der Mutter erkrankt 1 von 10.000 Säuglingen an Pertussis.



Das Risiko von Säuglingen in den ersten 3 Lebensmonaten an Pertussis zu erkranken, **sinkt durch eine Impfung** der Mutter in der Schwangerschaft um



Von der STIKO empfohlene Impfungen

● indiziert ○ möglich ● kontraindiziert

Influenza (Totimpfstoff)	●	einmal ab 2. Trimenon*
Pertussis mit Kombinationsimpfstoff	●	im 3. Trimenon**
Diphtherie	○	
Tetanus	○	● nach Exposition
Polio (IPV-Impfstoff)	○	
Masern, Mumps, Röteln (Lebendimpfstoff)	●	
Varizellen (Lebendimpfstoff)	●	
Hepatitis B	○	● nach Exposition

* bei Vorerkrankung (Asthma, Diabetes mellitus, Bluthochdruck) bereits im 1. Trimenon

** bei bekanntem Frühgeburtsrisiko bereits im 2. Trimenon



Für wen und wann ist die Impfung empfohlen?



Schwangere ab der 28. SSW (beste Schutzwirkung im frühen 3. Trimenon)

Bei erhöhter Wahrscheinlichkeit für eine **Frühgeburt** sollte die Impfung ins 2. Trimenon vorgezogen werden.

Eltern, Geschwister und Betreuende des Neugeborenen nach Möglichkeit spätestens 4 Wochen vor Geburt

FALSCHINFORMATIONEN ZUM IMPFEN WIRKSAM AUFLÄREN

THEMA Sicherheit



Autismus wird nicht durch Impfungen ausgelöst oder begünstigt.



»Impfungen können Autismus auslösen.«



Autismus-Diagnosen haben in einigen Teilen der Welt seit dem Jahr 2000 zugenommen. Gleichzeitig wurden auch mehr Impfungen verabreicht, als in den Jahrzehnten zuvor. Da liegt der Schluss nahe, die beiden Entwicklungen könnten ursächlich zusammenhängen. Doch das ist ein Trugschluss. Die steigenden Diagnose-Zahlen sind laut Expert:innen vielmehr auf eine erhöhte Aufmerksamkeit, bessere Testverfahren und genauere Definitionen zurückzuführen.



Bekannt wurde dieser Mythos in den 90er-Jahren, als ein ehemaliger Arzt ohne wissenschaftliche Grundlage behauptete, Kombinationsimpfstoffe (gegen Mumps, Masern und Röteln) könnten den Darm schädigen und so zu Autismus führen. Später wurde bekannt, dass seine Daten (von 12 Kindern) gefälscht waren und er mit der Verbreitung der Falschinformation eigene finanzielle Interessen verfolgte. Ihm wurde wegen unethischen Verhaltens die ärztliche Zulassung entzogen. Die Mitautor:innen sowie das Fachmagazin, das seine »Studie« veröffentlicht hatte, distanzieren sich öffentlich von seinen Aussagen und die Veröffentlichung wurde zurückgezogen.

Seitdem wurde in vielen großangelegten internationalen Studien untersucht, ob es einen solchen Zusammenhang geben könnte. Das Ergebnis: Autismus tritt bei geimpften und ungeimpften Kindern gleich häufig auf. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Belege für die Behauptungen des ehemaligen Arztes.



Fakt ist: Impfungen können als mögliche Ursache von Autismus ausgeschlossen werden.

Darauf weisen Ergebnisse zahlreicher Studien hin.



Das war ein Faktensandwich.
Mehr Infos auf www.rki.de/impfmythen

ROBERT KOCH INSTITUT



Impfmythen: Falschinformationen wirksam aufklären

Stand: 15.09.2025

FALSCHINFORMATIONEN ZUM IMPFEN WIRKSAM AUFLÄREN

THEMA Nutzen-Risiko-Abwägung



Vitamin A wird erfolgreich eingesetzt, um Komplikationen einer Masernerkrankung zu verhindern – vor Ansteckung und Übertragung bietet es keinen Schutz.



»Vitamin A ist eine wirksame Alternative zur Impfung gegen Masern.«



Seit einiger Zeit erhält die falsche Behauptung, Vitamin A bzw. Fischöl sei eine wirksame Alternative zur Masernimpfung, wieder vermehrt Aufmerksamkeit. Tatsächlich empfiehlt unter anderem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Vitamin A zur Unterstützung bei der Behandlung einer akuten Masernerkrankung. Daraus jedoch abzuleiten, dass Vitamin A die Impfung ersetzen könne, ist ein Trugschluss.



Anders als die Impfung kann die Vitamin-A-Gabe weder eine Infektion noch die Weiterverbreitung von Masern verhindern. Es wird vielmehr verabreicht, um einen möglichen Vitamin-A-Mangel auszugleichen. Die Vitamin-A-Gabe kann dazu beitragen, das Risiko für schwere Komplikationen einer Maserninfektion zu reduzieren, insbesondere wenn tatsächlich ein Vitamin-A-Mangel besteht.

Vitamin A sollte nur nach ärztlicher Verordnung, in klar festgelegter Dosierung und für einen begrenzten Zeitraum eingenommen werden. Eine unkontrollierte Einnahme, vor allem in zu hoher Dosierung, kann ernsthafte Gesundheitsschäden verursachen.



Vitamin A kann ein sinnvoller Teil der Behandlung von Masern sein, indem ein möglicher Mangel ausgeglichen wird.

Einen wirksamen Schutz vor einer Masernerkrankung kann die Einnahme von Vitamin A allerdings nicht leisten.

Die Impfung hingegen bietet einen wissenschaftlich belegten, sicheren und langfristigen Schutz vor einer Masernerkrankung – für sich selbst und für andere.



Das war ein Faktensandwich.
Mehr Infos auf www.rki.de/impfmythen

ROBERT KOCH INSTITUT



FALSCHINFORMATIONEN ZUM IMPFEN WIRKSAM AUFLÄREN

THEMA Sicherheit



Impfungen erhöhen nicht das Risiko für Allergien.

Ein möglicher Zusammenhang zwischen Impfungen und Allergien wurde vielfach wissenschaftlich untersucht.



»Impfungen fördern Allergien.«



In den vergangenen 20 Jahren sind viele neue Impfstoffe entwickelt, empfohlen und verabreicht worden, die vor Erkrankungen mit teilweise schwerwiegenden Folgen schützen. Gleichzeitig leiden mehr Menschen an Allergien als früher. Die Vermutung liegt nahe, dass beide Entwicklungen miteinander zusammenhängen könnten. Da Allergien die Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen können, ist es verständlich, sich zu sorgen.

Aus diesen Gründen untersuchten viele wissenschaftliche Studien mögliche Ursachen für die Entstehung von Allergien. Insbesondere in den methodisch zuverlässigen Untersuchungen konnte ein Zusammenhang zwischen Impfungen und Allergien nicht bestätigt werden. Es gibt sogar vereinzelte Hinweise, dass Impfungen vorübergehend vor neuen Allergien schützen könnten.

Für das vermehrte Auftreten von Allergien in den vergangenen Jahrzehnten werden nach wie vor verschiedene Erklärungen diskutiert. Die verbreitetste Theorie ist die »Hygienehypothese«. Demnach führe unser stärkeres alltägliches Bewusstsein für Hygiene und Sauberkeit zu weniger Kontakten mit Krankheitserregern (v.a. Bakterien, Pilze, Viren), Parasiten und Pollen. Das Immunsystem reagiere daraufhin unangemessen stark auf normalerweise harmlose Reize. Mehr Allergien seien die Folge.



Fakt ist: Impfungen fördern keine Allergien.

Für das vermehrte Auftreten von Allergien gibt es verschiedene Hypothesen, aber Impfungen können als Ursache für Allergien ausgeschlossen werden.



Das war ein Faktensandwich.
Mehr Infos auf www.rki.de/impfmythen

ROBERT KOCH INSTITUT



Titel der Präsentation

جدول التطعيم

التطعيمات
والتطعيمات السلبية

Sprache: Arabisch

التطعيم العمر

a a a a a a a a a a											b b b b b b b b b b											c c c c c c c c c c			
بداية من عمر 75 عاشًا	60-74	25-59	18-24	17	15-16	12-14	9-11	7-8	5-6	2-4	16-23	15	13-14	12	11*	8-10	5-7	4	3	2	06	00			
				J2		J1	U11/J1	U10	U9	U7a/U8	U7				U6		U5			U4		U2/U3			
															N		a		الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (جرعة لمرّة واحدة)						
																			(G3)	G2	b		G1		
B A				N	A2			N	A1	N					d	G3	N	G2	N	G1					
B A				N	A2			N	A1	N					d	G3	N	G2	N	G1					
N			B A3		N	A2			N	A1	N					d	G3	N	G2	N	G1				
										N					d	G3	N	G2	N	G1					
N					A1			N					d	G3	N	G2	N	G1							
				N											d	G3	N	G2	N	G1					
I S														d	G3	N	G2	N	G1						
										N			e		G3	N	G2	N	G1						
h S				N						G2		N	G1												
				N						G2		N	G1												
				N						G2		N	G1												
				N		I I		G1 G2																	
			N		G1																				
I S		I																							

Impfen bei Immundefizienz

Anwendungshinweise zu den von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen
(I) Grundlagenpapier

Grundlagen

Impfen bei Immundefizienz

Anwendungshinweise zu den von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen.
(II) Impfen bei 1. Primären Immundefekterkrankungen und 2. HIV-Infektion

Primärer Immundefekt und HIV

Impfen bei Immundefizienz

Anwendungshinweise zu den von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen. (III) Impfen bei hämatologischen und onkologischen Erkrankungen (antineoplastische Therapie, Stammzelltransplantation), Organtransplantation

Hämatol. und onkolog. Erk. Organ-/Stammzelltransplant. Asplenie

Impfen bei Immundefizienz

Anwendungshinweise zu den von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen. (IV) Impfen bei Autoimmunerkrankungen, bei anderen chronisch-entzündlichen Erkrankungen und unter immunmodulatorischer Therapie

Autoimmunerkrankungen, chron.-entz. Erkrankungen, immunmodulatorische Therapie

↓ Epidemiologisches Bulletin 45/2025 [PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei]	▪ Beschluss und wissenschaftliche Begründung für die Erweiterung der Indikationsimpfempfehlung zur Herpes-zoster-Impfung mit dem adjuvantierten Subunit-Totimpfstoff für Personen ≥ 18 Jahre mit einem erhöhten Risiko, an Herpes zoster zu erkranken ▪ ↓ Anhang zur wissenschaftlichen Begründung der STIKO für die Erweiterung der Indikationsimpfempfehlung zur Herpes-zoster-Impfung mit dem adjuvantierten Subunit-Totimpfstoff für Personen ≥ 18 Jahre mit einem erhöhten Risiko, an Herpes zoster zu erkranken	06.11.2025
↓ Epidemiologisches Bulletin 44/2025 [PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei]	▪ Beschluss zur Evaluation einer quadrivalenten Meningokokken-Impfung für Kleinkinder sowie ältere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ▪ ↓ Anhang zur wissenschaftlichen Begründung der STIKO zur Evaluation einer quadrivalenten Meningokokken-Impfung für Kleinkinder sowie ältere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	30.10.2025
↓ Epidemiologisches Bulletin 33/2025 [PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei]	▪ Stellungnahme der STIKO zur Anwendung des 20-valenten Pneumokokken-Konjugatimpfstoffs (PCV20) im Säuglings- und Kleinkindalter: erneute Evaluierung unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer dynamischen Transmissionsmodellierung	14.08.2025

STIKO: Erweiterung der Herpes-zoster-Indikationsimpfempfehlung für Personen ≥ 18 Jahre mit erhöhtem Erkrankungsrisiko

45
2025

6. November 2025

Auszug Tabelle 2 | Empfehlungen zu Standardimpfungen des Erwachsenenalters sowie zu Indikations- (Berufs- und Reiseimpfungen) und Auffrischimpfungen für alle Altersgruppen

Impfung gegen	Kategorie	Indikation	Anmerkungen (Packungsbeilage/Fachinformation beachten)
Herpes zoster (HZ)	I	Personen ≥ 18 Jahre mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge einer angeborenen bzw. erworbenen, insbesondere einer iatrogenen Immundefizienz oder infolge schwerer Ausprägung einer chronischen Grunderkrankung, z. B. Personen mit bzw. nach: ▶ Hämatopoetischer Stammzelltransplantation (HSZT) ▶ Zellbasierten Therapien ▶ Solider Organtransplantation ▶ Immunsuppressiver Medikation (z. B. Rituximab, JAK-Inhibitoren, Anifrolumab [Typ I Interferon-Rezeptorblocker], zytostatischer Chemotherapie) ▶ Malignen neoplastischen Krankheiten ▶ HIV-Infektion ▶ Rheumatoider Arthritis ▶ Systemischem Lupus erythematodes ▶ Chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen ▶ Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) oder Asthma bronchiale ▶ Chronischer Niereninsuffizienz ▶ Diabetes mellitus	▶ 2-malige Impfung mit dem adjuvantierten HZ/su-Totimpfstoff im Abstand von 2–6 Monaten Leichte oder unkomplizierte bzw. medikamentös gut kontrollierte Formen chronischer Grunderkrankungen bei Personen zwischen 18 und 59 Jahren sind nach Einschätzung der STIKO nicht mit einem deutlich erhöhten HZ-Risiko verknüpft und daher nicht von der Empfehlung umfasst.

STIKO: **Quadrivalente Meningokokken-** **Impfung** für Kleinkinder sowie ältere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

44
2025

30. Oktober 2025

- im **Alter von 12 bis 14 Jahren MenACWY** mit einer Dosis quadrivalenter Konjugatimpfstoff (z.B. bei J1)
- Nachholimpfungen bis zum 25. Geburtstag
- Entfall bisherige Empfehlung gegen MenC im Kleinkindalter
- **Men B Standardimpfung von Säuglingen** (Epi. Bull. 3/2024), Nachholimpfungen bis zum 5. Geburtstag

Fallzahl/100.000

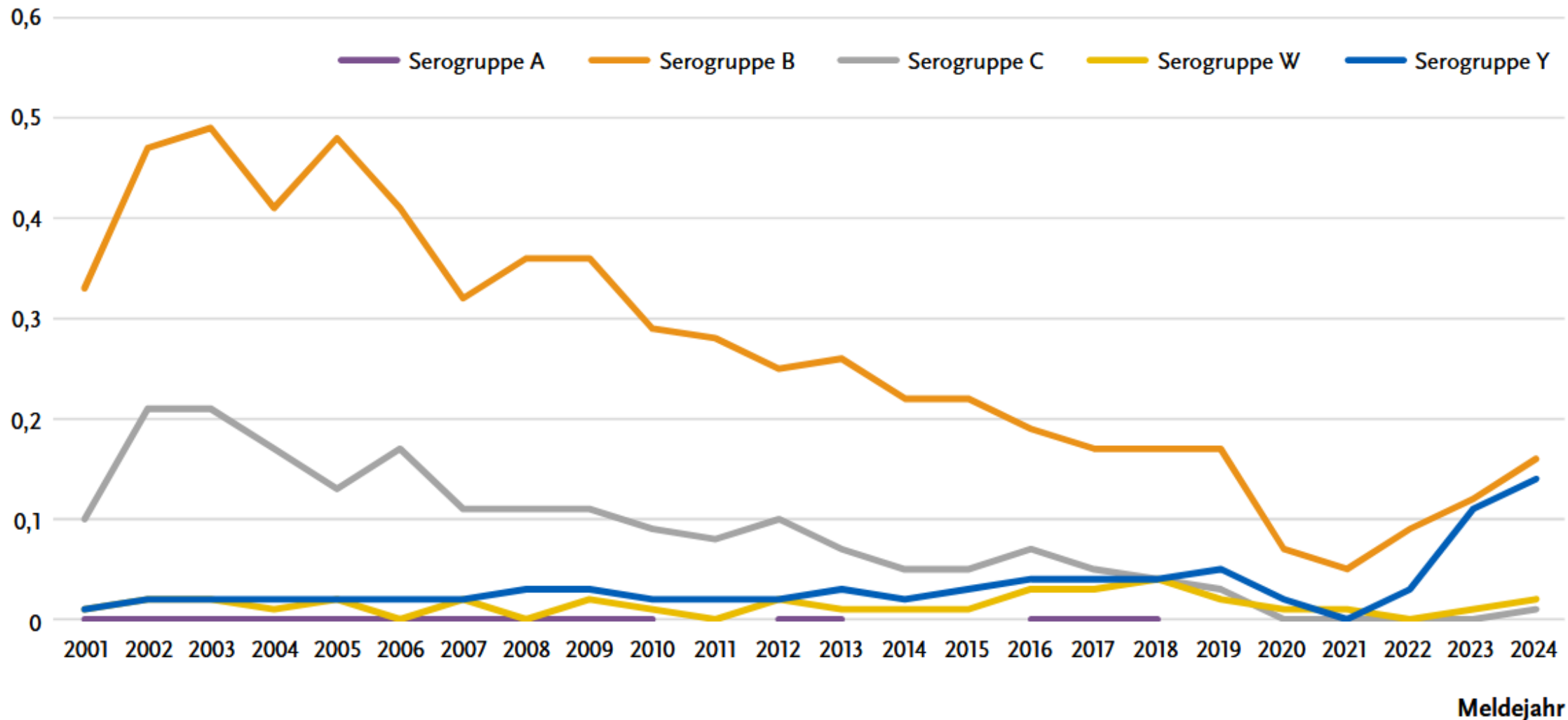
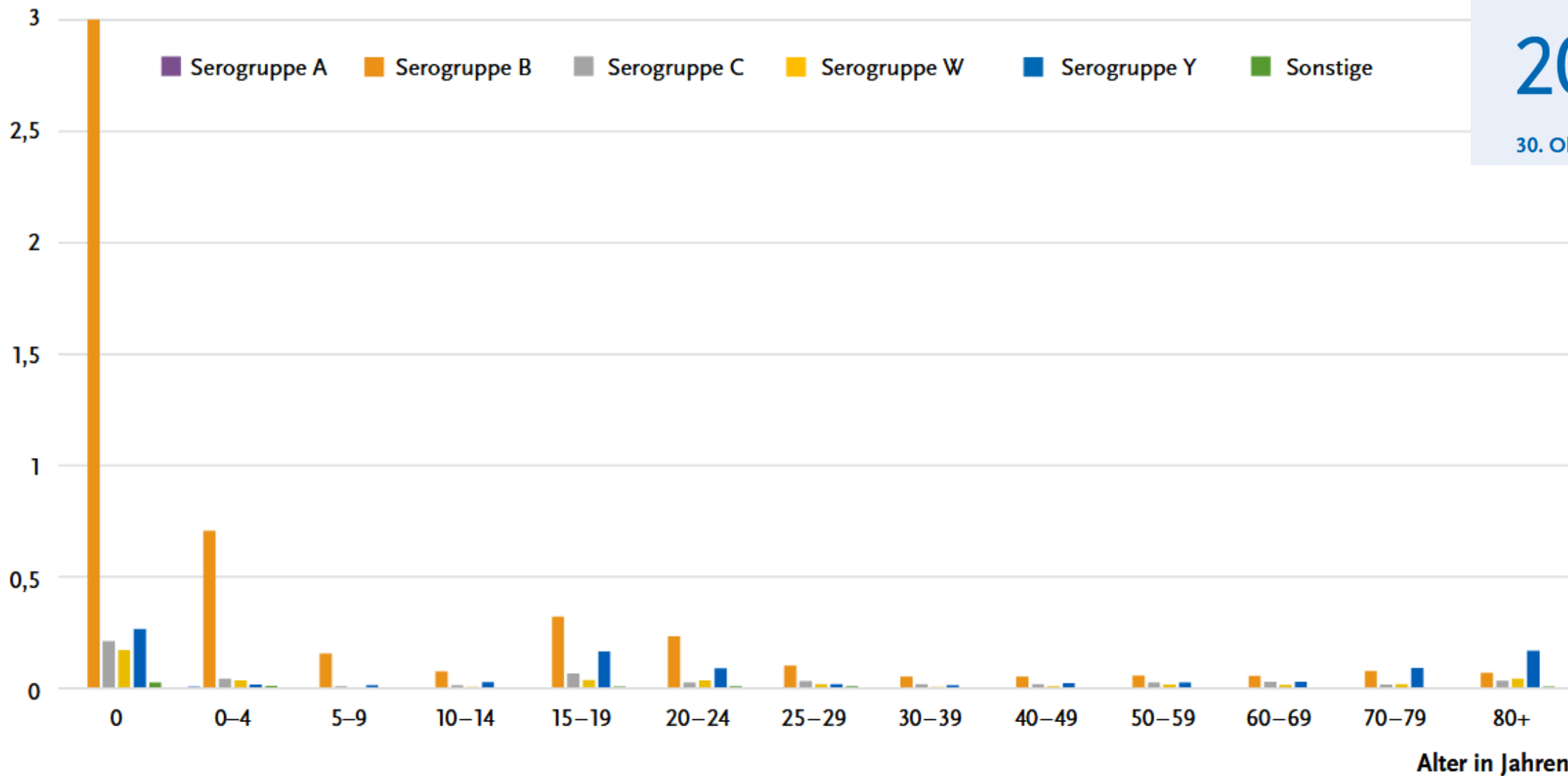


Abb. 1 | Inzidenz der invasiven Meningokokken-Erkrankungen der Serogruppen A, B, C, W und Y im Zeitverlauf in Deutschland (2001–2024)

Quelle: Meldedaten gemäß IfSG

Fallzahl/100.000



44

2025

30. Oktober 2025

Abb. 2 | Mittlere jährliche Inzidenz (2015–2024) invasiver Meningokokken-Erkrankungen nach Alter und Serogruppen

Quelle: Meldedaten gemäß IfSG

Fallzahl/100.000

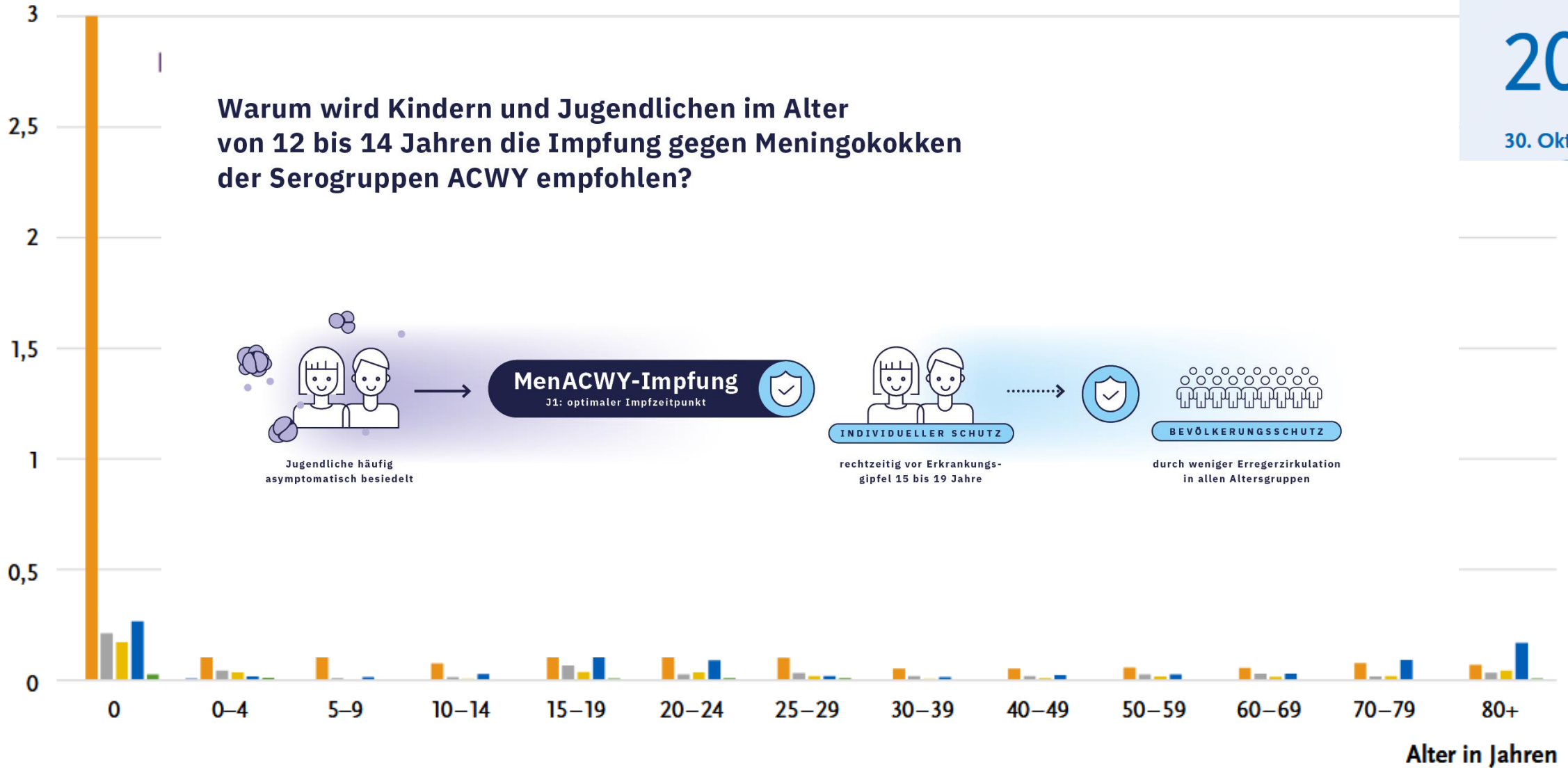


Abb. 2 | Mittlere jährliche Inzidenz (2015–2024) invasiver Meningokokken-Erkrankungen nach Alter und Serogruppen

Quelle: Meldedaten gemäß IfSG

STIKO: Erneute Evaluation und Stellungnahme zur PCV20-Anwendung im Säuglings- und Kleinkindalter

33
2025

14. August 2025

- Seit März 2024 PCV20 Impfstoff **ab 6 Wochen in EU zugelassen**
- Immunogenitätsdaten nach PCV20-Impfung zeigen jedoch für alle mit PCV13 vergleichbare ST **geringere IgG-AK-Konzentrationen**
- **STIKO bleibt bei der bisherigen Empfehlung**
- 2+1-Impfung mit PCV13 oder PCV15 für die Grundimmunisierung von gesunden, reifgeborenen Säuglingen
- 3+1-Impfschemas mit PCV13 oder PCV15 für Frühgeborene

Beschluss zur Aktualisierung der Empfehlung der STIKO zur **Indikationsimpfung** für Kinder und Jugendliche mit Risikofaktoren im Alter von **≥ 2 bis 17 Jahren** gegen **Pneumokokken**-Erkrankungen

2
2026

8. Januar 2026

- Angeborene oder erworbene Immundefekte
- Sonstige chronische Krankheiten
- Anatomische oder fremdkörperassoziierte Risiken für eine Pneumokokken-Meningitis
- **Impfung mit PCV20**

Impfstatus	empfohlene Impfung
Keine Impfung	PCV20
PCV10 oder PCV13 oder PCV15	PCV20 im Abstand von 1 Jahr
PPSV23	PCV20 im Abstand von 6 Jahren (bei ausgeprägter Immun- defizienz Impfung im Abstand von 1 Jahr möglich)
PCV13/PCV15 + PPSV23	

Tab. 1 | Umsetzung der Pneumokokken-Indikationsimpfung für Kinder (≥ 2 Jahre), Jugendliche und Erwachsene mit Risikofaktoren unter Berücksichtigung des aktuellen Impfstatus

Fall – Asplenie

50-jährige Patientin, Splenektomie bei einer schwer zu behandelnden chronischen Immuntrombozytopenie

Welche Impfungen sind besonders wichtig?

In welchen Abständen Wiederholungsimpfungen?

Bestehen Kontraindikationen für Lebendimpfungen?



Impfungen bei Hypo- oder Asplenie (Entfernung der Milz oder Ausfall der Organfunktion)

Stand: 13.04.2026



EN



Impf-Infos



Indikationsimpfungen
für Risikogruppen



Indikationsimpfungen für **Risikogruppen**

Klinische Situation

Auswahl

Risiko

Risikogruppe

Gesundheitliche Risiken

Art des Risikos

Anatomische oder funktioneller Asplenie (I)

Erreger (Links führen zu detaillierten Informationen in den STIKO Impfe mpfehlungen)

- [Haemophilus influenzae \(Hib\)](#)
- [Pneumokokken](#)
- [Meningokokken](#)

ASPLENIE-NET

PRÄVENTION BEI SPLENEKTOMIE UND ASPLENIE

NOTFALLAUSWEIS

MEDICAL EMERGENCY CARD ASPLENIA

ASPLENIE

(FEHLENDE MILZ/MILZFUNKTION)

ES BESTEHT EIN ERHÖHTES RISIKO FÜR
LEBENSBEDROHLICHE INFEKTIONEN!

NOTFALLANTIBIOTIKATHERAPIE OPTIONEN

bei Kindern

p.o.	Amoxicillin/Clavulansäure 3 x 25 mg/kg/KG
i.v.	Ceftriaxon 1 x 80 mg/kg/KG

bei Erwachsenen

p.o.	Amoxicillin/Clavulansäure 3 x 1000 mg
i.v.	Ceftriaxon 1 x 2000 mg

bei Allergie

Penicillinallergie	Cefpodoximproxetil
β -Laktamallergie	Clarithromycin

Empfehlungen zur Antibiotikaphylaxe siehe
www.asplenie-net.org

ERHÖHTES INFEKTIONSRISIKO

Sepsis mit bekapselten Bakterien: Pneumokokken (häufig),
Meningokokken, *Haemophilus influenzae*

Sepsis nach Tierbissen: *Capnocytophaga canimorsus*

Parasitosen: *Babesia* (Zeckenstiche), Malaria

**BEI FIEBER ODER INFEKTIONSZEICHEN IST EINE
SCHNELLE ANTIBIOTIKATHERAPIE ANGEZEIGT!**



STIKO: Erweiterung der Empfehlung zur Indikationsimpfung und postexpositionellen Chemoprophylaxe gegen *Haemophilus influenzae* Typ b

34
2025

Epidemiologisches Bulletin

Tabelle | Postexpositionelle Impfungen sowie andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe (Anpassung der Tabelle 7 der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission)

Prophylaxe gegen	Indikationsgruppe	Empfohlenes Vorgehen (Packungsbeilage/Fachinformation beachten)
<i>Haemophilus influenzae</i> Typ b (Hib)	Chemoprophylaxe Nach engem (<i>face-to-face</i>) Kontakt mit einer Person mit invasiver Hib-Infektion oder Kontakt zu deren oropharyngealen Sekreten wird eine Chemoprophylaxe für folgende Personengruppen empfohlen: ► ungeimpfte oder unvollständig geimpfte, in Gemeinschaftseinrichtungen exponierte Kindern <5 Jahre ► alle Kontaktpersonen mit medizinisch begründbarem erhöhtem Risiko für invasive Hib-Erkrankungen* ► alle Haushaltsmitglieder der erkrankten Person, wenn sich in ihrem Haushalt mindestens ein ungeimpftes oder unvollständig geimpftes Kind <5 Jahre oder eine Person mit medizinisch begründbarem erhöhtem Risiko für invasive Hib-Erkrankungen* befindet. Bewohnende von Einrichtungen (z. B. Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende oder Wohnungslose, Internate, Wohnheime, Kasernen, Justizvollzugsanstalten), die haushaltsähnlichen Kontakt haben, werden als Haushaltsmitglieder betrachtet. In Ausbruchssituationen zusätzlich: ► alle Kinder und deren Betreuende (unabhängig von Impfstatus und Alter) derselben Gruppe einer Gemeinschaftseinrichtung für Kinder <5 Jahre, wenn dort innerhalb von etwa 2 Monaten ≥ 2 Fälle aufgetreten sind und in der Einrichtung nicht oder nicht vollständig geimpfte Kinder <5 Jahre betreut werden ► alle enge Kontaktpersonen (<i>face-to-face</i> -Kontakt; unabhängig vom Impfstatus und Alter), die im Ausbruchsgeschehen selbst engen und regelmäßigen Kontakt zu vulnerablen Personen* haben	Chemoprophylaxe Rifampicin (erste Wahl): ≥ 1 Monat: 1 x 20 mg/kg Körpergewicht (maximal 600 mg) p. o. für 4 Tage ≥ 18 Jahre: 1 x 600 mg p. o. für 4 Tage Ceftriaxon:** < 12 Jahre: 50 mg/kg Körpergewicht (max. 1.000 mg/Tag) parenteral für 2 Tage ≥ 12 Jahre und Erwachsene: 1.000 mg/Tag parenteral für 2 Tage Levofloxacin:** in allen Altersgruppen: 8 – 10 mg/kg Körpergewicht (max. 1.000 mg/Tag) p. o. für 4 Tage Für eine Chemoprophylaxe bei Schwangeren sollte die Wahl des Antibiotikums individuell und unter Berücksichtigung der Hinweise in den Fachinformationen entschieden werden. Falls eine Prophylaxe indiziert ist, sollte sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens 7 Tage nach Beginn der Erkrankung des Indexfalls, begonnen werden. In Ausbruchssituationen kann die PEP bis zu Tag 28 nach Erkrankungsbeginn beim Indexfall für enge Kontaktpersonen, die selbst vulnerabel sind oder, die im Ausbruchsgeschehen engen und regelmäßigen Kontakt zu vulnerablen Personen haben, sinnvoll sein.
	Impfung Ungeimpfte oder unvollständig geimpfte Kinder <5 Jahre sollten gegen Hib nachgeimpft werden. In Ausbruchssituationen zusätzlich: ► Hib-Impfung für Menschen mit einem medizinisch begründbaren erhöhten Risiko* für eine invasive Hib-Erkrankung, die einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind	1-malige Impfung mit mit altersentsprechend zugelassenem Impfstoff (z. B. Act-Hib, Pentavac oder ein vergleichbarer Impfstoff mit Hib-Komponente) Für Hib-Kombinationsimpfstoffe, die regulär im Kindesalter zur Anwendung kommen, besteht aufgrund höherer Tetanustoxoid- und Diphtherietoxoid- oder <i>Bordetella-pertussis</i> -Antigengehalte als Tdap-Kombinationsimpfstoffe für Erwachsene ein potenziell erhöhtes Risiko für lokale und systemische Reaktogenität.
	* Medizinisch begründbares erhöhtes Risiko für eine invasive Hib-Erkrankung besteht z. B. aufgrund von Asplenie, Drogenkonsum, prekärer Wohnsituation/Wohnungslosigkeit, chronischer Leber- oder Nierenerkrankung oder Mangelernährung. ** Unter Berücksichtigung von Kontraindikationen, Alter, möglichen Nebenwirkungen sowie Interaktionspotenzial, Therapiedauer und Dosierungsschema der verwendeten Substanz und ggf. auch der Sicherstellung einer möglichst guten Therapieadhärenz bei schwer erreichbaren Personengruppen (z. B. drogengebrauchende oder wohnungslose Personen) kann die Chemoprophylaxe alternativ zu Rifampicin auch mit Ceftriaxon oder Levofloxacin erfolgen. Bei Nicht-Verfügbarkeit kann auch Ciprofloxacin (Anwendungshinweise s. Fachinformation) zur PEP angewandt werden.	

Infoblatt: Lebensbedrohliche Erkrankungen durch Hib-Bakterien in Hamburg

Stand: 28.04.2026

In Hamburg sind seit Oktober 2024 mehrere Menschen schwer an einer Hirnhautentzündung oder Blutvergiftung durch Hib-Bakterien (*Haemophilus influenzae* Typ b) erkrankt. Drei Personen sind verstorben. Die erkrankten Personen waren vorwiegend drogengebrauchende und wohnungslose Menschen. Informationen zu Hib und zu Schutzmöglichkeiten bietet dieses Infoblatt.

Ein Projekt von:
Institut für Internationale Gesundheit
Charité Center for Global Health

IMPFEN SCHÜTZT

MOŻESZ SIĘ ZASZCZEPIĆ.

Bez stałego miejsca zamieszkania, bez ubezpieczenia zdrowotnego, bez dowodu tożsamości. Poinformuj się w placówkach społecznych i medycznych, które znasz.

ТЫ МОЖЕШЬ ПОЛУЧИТЬ ПРИВИВКУ.

Если у тебя нет постоянного жилья, медицинской страховки или документов. Получи информацию в социальных и медицинских учреждениях, которые ты знаешь.

YOU CAN GET VACCINATED.

Even with no fixed address, no health insurance, no documents. Get informed in the social or health care services you know.

DU KANNST DICH IMPFEN LASSEN.

Auch ohne festen Wohnsitz, ohne Krankenversicherung, ohne Papiere. Informiere dich in den sozialen und medizinischen Einrichtungen, die du kennst.

می توانید واکسینه شوید.

بدون نیاز به کارت اقامت یا هرگونه مدرک شناسایی دیگر، بدون نیاز به بیمه درمانی، بدون اوراق رسمی، برای کسب اطلاع بیشتر به مراکز خدماتی برای افراد بی خانمان، مراجعه کنید.

Inzidenz: Fälle/100.000 Einw. und Jahr

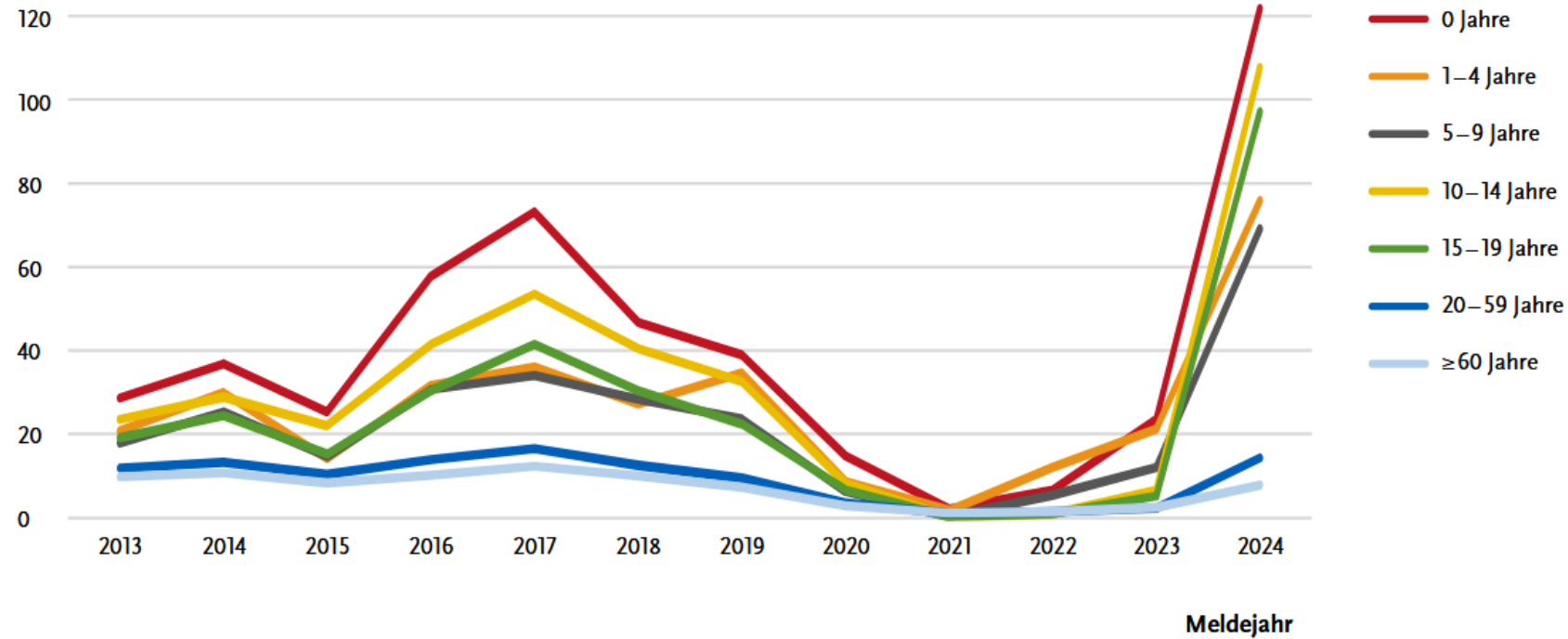


Abb. 2 | Keuchhusteninzidenz nach Altersgruppe und Meldejahr, Stand 19.11.2024 (übermittelte Fälle entsprechend der Referenzdefinition; 2024 nur bis zum aktuellen Datenstand darstellbar)

Pertussis

S/A

Erwachsene sollen die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap-Kombinationsimpfung erhalten.

KURZ & KNAPP: FAKTENBLÄTTER ZUM IMPFEN

Impfungen in der Schwangerschaft Schwerpunkt Pertussis (Keuchhusten)

Wovon und wie schützt die Pertussis-Impfung?



Schutz durch die Pertussis-Impfung



Wie hoch ist die Schutzwirkung der Impfung?

Ohne Impfung der Mutter erkrankten 11 von 10.000 Säuglingen an Pertussis.

Das Risiko von Säuglingen in den ersten 3 Lebensmonaten an Pertussis zu erkranken, sinkt durch eine Impfung der Mutter in der Schwangerschaft.

Pertussis (Keuchhusten) in der Schwangerschaft

- Pertussis ist hoch ansteckend und weit verbreitet.
- Die häufigsten, schweren Komplikationen treten bei Neugeborenen auf, die noch nicht geimpft werden können.
- Eine Pertussis-Infektion der Mutter kann bei Säuglingen in den ersten Lebensmonaten Infektionen, Krankenhausaufweisungen und Todesfälle verhindern.
- Eine Impfung schützt Mutter und Kind.
- Für Pertussis ist in Deutschland kein Einzelimpfstoff zugelassen. Für Schwangere stehen 3- oder 4-fach-Impfstoffe zur Verfügung.

Wie sicher ist die Pertussis-Impfung?

● keine erheblichen Risiken für

I

Schwangere zu Beginn des 3. Trimenons (ab der 28. Schwangerschaftswoche).

Bei erhöhter Wahrscheinlichkeit für eine Frühgeburt sollte die Impfung ins 2. Trimenon vorgezogen werden.

Folgende Personen sollen **alle 10 Jahre 1 Dosis** Pertussis-Impfstoff erhalten:

- **enge Haushaltskontaktpersonen** (z. B. Eltern,^{*} Geschwister, Freunde) **und Betreuende** (z. B. Tagesmütter, Babysitter, ggf. Großeltern) **eines Neugeborenen** nach Möglichkeit spätestens 4 Wochen vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin

B

Personal im Gesundheitsdienst sowie in Gemeinschaftseinrichtungen soll alle 10 Jahre 1 Dosis Pertussis-Impfstoff erhalten.

Impfungen in der Schwangerschaft

Schwerpunkt Pertussis (Keuchhusten)



Wovor und wie schützt die Pertussis-Impfung?

Risiken der Pertussis-Erkrankung



starker, atemraubender Husten, Lungenentzündung, Tod



vorzeitige Wehen



Atemaussetzer, Lungenentzündung, Tod

Schutz durch die Pertussis-Impfung

□ Immunität

Y Immunglobulin-G-Antikörper



Pertussis (Keuchhusten) in der Schwangerschaft

- ❗ **Pertussis ist hoch ansteckend und weit verbreitet.**
- ❗ Die häufigsten, schweren Komplikationen treten bei Neugeborenen auf, die noch nicht geimpft werden können.
- ❗ Eine Pertussis-Impfung der Mutter kann bei Säuglingen in den ersten Lebensmonaten Infektionen, Krankenhauseinweisungen und Todesfälle verhindern.
- ❗ Eine Impfung schützt Mutter **und** Kind.
- ❗ Für Pertussis ist in Deutschland kein Einzelimpfstoff zugelassen. Für Schwangere stehen 3- oder 4-fach-Impfstoffe zur

Neue STIKO-Empfehlung für Pertussis seit 2020: **Impfung zu Beginn des 3. Trimenons (ab 28. SSW)**; bei erhöhter Wahrscheinlichkeit für eine Frühgeburt schon im 2. Trimenon. **Die Impfung erfolgt unabhängig vom Abstand zu einer vorher verabreichten Pertussis-Impfung und in jeder Schwangerschaft!**

Pertussis Impfung - auch im Verletzungsfall

Tabelle 9 | Tetanus-Immunprophylaxe im Verletzungsfall

	Dokumentierter Tetanus-Impfstatus	Zeit seit letzter Impfung	DTaP/ Tdap ^{b,e}	Tetanusimmun- globulin (TIG) ^c
Saubere gering- fügige Wunden	Ungeimpft oder unbekannt		Ja	Ja
	< 3 Impfstoffdosen		Ja ^d	Nein
	≥ 3 Impfstoffdosen	≥ 10 Jahre	Ja	Nein
		< 10 Jahre	Nein	Nein
Alle anderen Wunden ^a	< 3 Impfstoffdosen oder unbekannt		Ja ^d	Ja
	≥ 3 Impfstoffdosen	≥ 5 Jahre	Ja	Nein
		< 5 Jahre	Nein	Nein

- a** Tiefe und/oder verschmutzte (mit Staub, Erde, Speichel, Stuhl kontaminierte) Wunden, Verletzungen mit Gewebszertrümmerung und reduzierter Sauerstoffversorgung oder Eindringen von Fremdkörpern (z. B. Quetsch-, Riss-, Biss-, Stich-, Schusswunden), schwere Verbrennungen und Erfrierungen, Gewebsnekrosen, septische Aborte.
- b** Kinder < 6 Jahre erhalten einen Kombinationsimpfstoff mit DTaP, ältere Kinder und Jugendliche Tdap. Erwachsene erhalten ebenfalls Tdap, wenn sie noch keine Pertussis-Impfung im Erwachsenenalter (≥ 18 Jahre) erhalten haben oder sofern eine aktuelle Indikation für eine Pertussis-Impfung besteht (s. Tab. 2).
- c** TIG = Tetanus-Immunglobulin. TIG (im Allgemeinen 250 IE) wird simultan mit einer DTaP- bzw. Tdap-Impfstoffdosis aber kontralateral appliziert. Die TIG-Dosis kann auf 500 IE erhöht werden bei:
(a) infizierten Wunden, bei denen eine angemessene chirurgische Behandlung nicht innerhalb von 24 h gewährleistet ist; (b) tiefen oder kontaminierten Wunden mit Gewebszertrümmerung und reduzierter Sauerstoffversorgung; (c) Eindringen von Fremdkörpern (z. B. Biss-, Stich- oder Schusswunden); (d) schweren Verbrennungen und Erfrierungen, Gewebsnekrosen und septischen Aborten.
- d** Für Personen, bei denen die Grundimmunisierung begonnen, aber noch nicht abgeschlossen ist (z. B. Säuglinge), muss der Abstand zur letzten Impfstoffdosis berücksichtigt werden. Eine postexpositionelle Impfung am Tag der Wundversorgung ist nur sinnvoll, wenn der Abstand zu der vorhergehenden Impfstoffdosis mindestens 28 Tage beträgt. Bezüglich des Abschlusses einer Grundimmunisierung gelten die Nachholimpfempfehlungen der STIKO.
- e** Nach Mitteilungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) von April 2018 werden die Kosten für Tetanus-Kombinationsimpfungen generell übernommen, soweit nach Empfehlungen der STIKO nach einem Arbeitsunfall eine Tetanus-Prophylaxe erforderlich ist.



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/368204/2025
EMA/H/C/006304

VacPertagen (Keuchhustenimpfstoff (rekombinant, azellulär, aus Komponenten, adsorbiert))

Übersicht über VacPertagen und warum es in der EU zugelassen ist

Was ist VacPertagen und wofür wird es angewendet?

VacPertagen ist ein Impfstoff, der als Auffrischungsimpfung zum Schutz gegen Keuchhusten bei Jugendlichen ab 12 Jahren und Erwachsenen, die zuvor gegen die Krankheit geimpft wurden, angewendet wird.

Es wird auch bei Schwangeren zum Schutz ihrer Säuglinge gegen Keuchhusten in den ersten Monaten nach der Geburt angewendet.

VacPertagen enthält als Wirkstoffe zwei Proteine aus den Keuchhustenbakterien.

IMPFKALENDER

Impfungen und
passive Immunisierungen

Sprache: Deutsch

Impfungen und passive Immunisierungen
sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.

Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort,
entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission
(STIKO), 2026. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



IMPFUNG

ALTER

	in Wochen			in Monaten						in Jahren										60-74	ab 75
	00	06	2	3	4	5-7	8-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-11	12-14	15-16	17	18-24	25-59
	U2/U3		U4			U5		U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J1		J2		
RSV	Monoklonale Antikörper (Einmaldosis) ^a						N														
Rotaviren		G1 ^b	G2	(G3)																	
Tetanus ^c		G1	N	G2		N		G3 ^d		N			A1	N		A2		N		A ^B	
Diphtherie ^c		G1	N	G2		N		G3 ^d		N			A1	N		A2		N		A ^B	
Pertussis ^c		G1	N	G2		N		G3 ^d		N			A1	N		A2		N		A3 ^B	N
Haemophilus influenzae Typ b ^c		G1	N	G2		N		G3 ^d		N											
Poliomyelitis ^c		G1	N	G2		N		G3 ^d			N					A1		N			
Hepatitis B ^c		G1	N	G2		N		G3 ^d				N									
Pneumokokken ^c		G1	N	G2		N		G3 ^d		N											S ⁱ
Meningokokken B ^c		G1	N	G2		N			G3 ^e		N										
Masern								G1	N	G2				N						S ^h	
Mumps, Röteln								G1	N	G2				N							
Varizellen								G1	N	G2				N							
Humane Papillomviren																G1 G2 ^f		N			
Meningokokken ACWY																	G1		N		
COVID 19																				G ^j	
Herpes zoster																					S ^j (jährlich)
Influenza																					G1 G2 ^k (jährlich)
RSV (Impfung)																					S ^l

ERLÄUTERUNGEN

G GRUNDIMMUNISIERUNG

(in bis zu 3 Teilimpfungen G1 – G3)

S STANDARDIMPFUNG

A AUFRISCHIMPFUNG

N NACHHOLIMPFUNG

(Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften

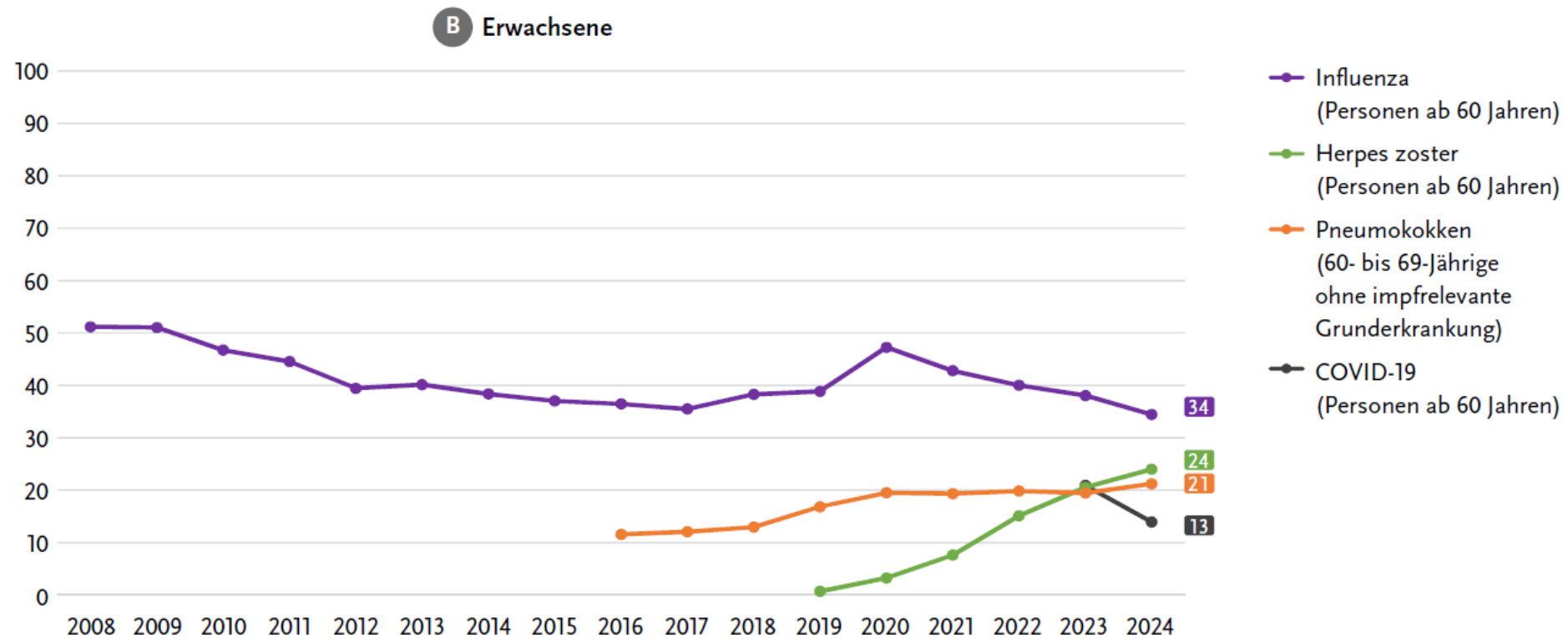
bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

U Früherkennungsuntersuchung

J Jugenduntersuchung

(J1 im Alter von 12–14 Jahren)

Impfquote ausgewählte Impfungen 2008-2024, Erwachsene



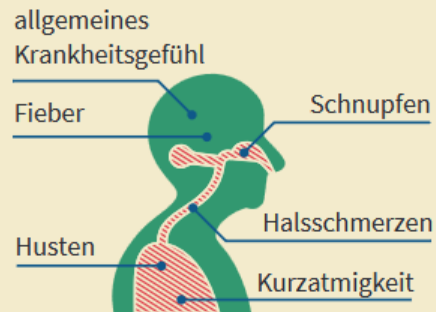
KURZ & KNAPP: FAKTENBLÄTTER ZUM IMPFEN

RSV-Impfung für ältere Menschen



Wovor schützt die Impfung?

Durch RSV ausgelöste Erkrankungen



Mögliche Komplikationen

- Lungenentzündung
- Verschlechterung von bestehenden chronischen Erkrankungen
- Krankenhauseinweisung
- Intensivmedizinische Behandlung
- Herzversagen
- selten Tod

Jährliche Auswirkungen der RSV-Infektionen in Europa bei Personen ab 60 Jahren

(in 2019)



**3,1 Mio.
Erkrankungen**



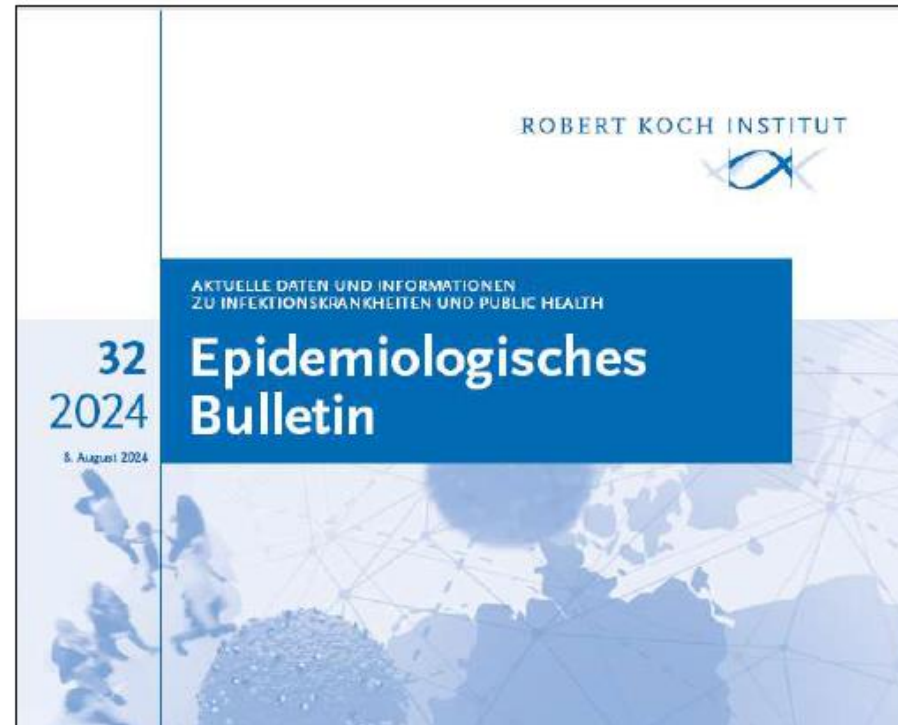
**270.000
Hospitalisierungen**



**19.500
Todesfälle**

Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV)

- ! Weltweit verbreiteter Erreger, der in jedem Lebensalter Erkrankungen verursachen kann.
- ! RSV-Infektionen ähneln in Saisonalität und Symptomatik der Influenza.
- ! Reinfektionen sind häufig, insbesondere bei Erwachsenen mit regelmäßigem Kontakt zu Kleinkindern.
- ! Das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf nimmt bei Erwachsenen mit dem Alter zu.
- ! Personen ≥ 75 Jahre haben das größte Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf.

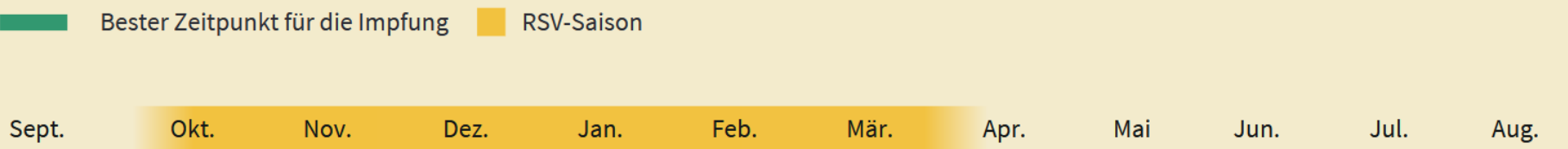


STIKO: 1-malige RSV-Impfung für alle ≥ 75 -Jährigen sowie Indikationsimpfung für 60- bis 74-Jährige mit Risikofaktoren

Neue STIKO-Empfehlung im EpiBul 32/2024 vom 08.08.2024



Wann ist der beste Zeitpunkt für die Impfung?



1-malige Impfung mit einem proteinbasierten RSV-Impfstoff

(s. FAQ Rückseite)



Respiratorisches Synzytial Virus (RSV)

S	Personen ≥ 75 Jahre.	1-malige Impfung möglichst vor Beginn der RSV-Saison mit einem proteinbasierten oder dem mRNA-RSV-Impfstoff. Auf Basis der aktuellen Datenlage kann noch keine Aussage zur Notwendigkeit von Wiederholungsimpfungen getroffen werden. Leichte oder unkomplizierte bzw. medikamentös gut kontrollierte Formen der genannten chronischen Erkrankungen gehen nach jetzigem Wissensstand nicht mit einem deutlich erhöhten Risiko für einen schweren RSV-Krankheitsverlauf einher.
	I Personen im Alter von 60–74 Jahren mit schweren Ausprägungen von chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane, chronischen Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen, hämato-onkologischen Erkrankungen, Diabetes mellitus (mit Komplikationen), einer chronischen neurologischen oder neuromuskulären Erkrankung oder einer schweren angeborenen oder erworbenen Immundefizienz. Bewohnende von Einrichtungen der Pflege im Alter von 60–74 Jahren.	

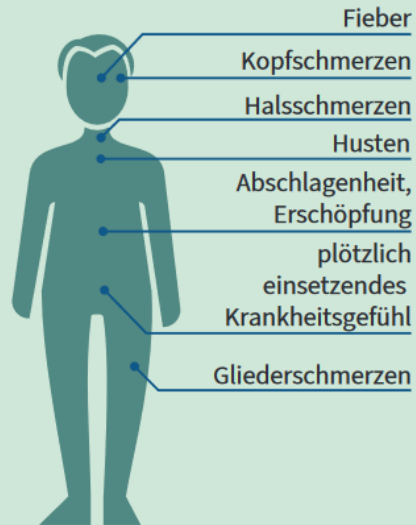
KURZ & KNAPP: FAKTENBLÄTTER ZUM IMPFEN

Influenza-Impfung



Wovor schützt die Impfung?

Durch Influenza-Viren
ausgelöste Erkrankung



Komplikationen

- Lungenentzündung (auch als Sekundärinfektion)
- Verschlechterung einer chronischen Lungenerkrankung
- kardiovaskuläre Folgen (bis hin zu Schlaganfall, Herzinfarkt)
- selten: Gehirnentzündung, Herzmuskelentzündung
- bei Kindern: Mittelohrentzündung
- bei schwerem Verlauf oder schwerer Vorerkrankung: Tod

Influenza („echte“ Grippe)

- ! Die Influenza ist eine durch Influenza-Viren ausgelöste, saisonal häufig vorkommende akute Krankheit. Sie kann ernst bis lebensbedrohlich verlaufen.
- ! Vor allem bei Menschen mit Risikofaktoren sind schwere Krankheitsverläufe möglich.
- ! Die Zahl der Influenza-assoziierten Todesfälle schwankt von Jahr zu Jahr stark (mehrere Hundert bis über 20.000 Tote).
- ! Infektionsweg: hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion, aber auch über kontaminierte Hände und Oberflächen mit nachfol-

Konzept quadrivalenter Impfstoff (QIV)

2012, 87, 461–476

No. 47



World Health
Organization

Organisation mondiale de la Santé

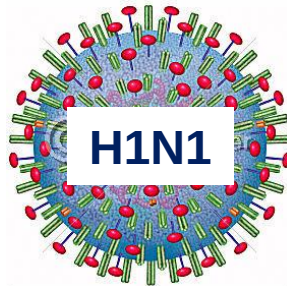
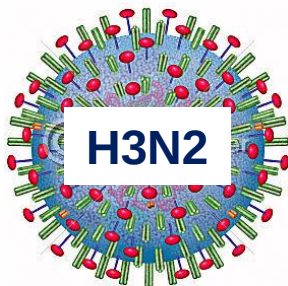
Weekly epidemiological record
Relevé épidémiologique hebdomadaire

23 NOVEMBER 2012, 87th YEAR / 23 NOVEMBRE 2012, 87^e ANNÉE

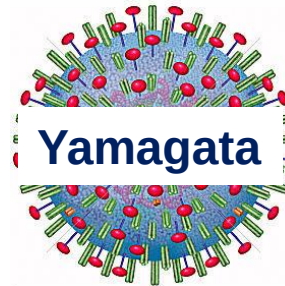
No. 47, 2012, 87, 461–476

<http://www.who.int/wer>

11/2012: „*Quadrivalent influenza vaccines that could potentially provide wider protection against influenza B viruses are becoming available and recommendations should not be limited to trivalent vaccine formulations.*“



2 A Virus-Subtypen



2 B Virus-Subtypen

Influenza-Impfstoffe

Neue STIKO-Impfempfehlung seit 01.08.2024

- Seit September 2023 empfiehlt die WHO den Wechsel von quadrivalenten zu trivalenten Influenza-Impfstoffen ohne B/Yamagata Linie.
- Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) ist dieser Empfehlung im März 2024 gefolgt.

Influenza-Impfstoffe

Anwendungshinweise für die Saison 2024/2025

- Verwendung von inaktivierten quadrivalenten Impfstoffen (nicht Lebendimpfstoffe) ist während der Übergangszeit (bis max. zur Saison 2025/2026) weiterhin möglich
- Für den Fall, dass kein trivalenter Lebendimpfstoff (Fluenz®) verfügbar ist:
 - Empfehlung zur Verwendung eines inaktivierten Influenza-Impfstoffs (Totimpfstoff)
 - Es wird nicht empfohlen in der Saison 2024/2025 einen quadrivalenten Lebendimpfstoff zu verwenden.



Mitteilung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut

Beschluss der STIKO zur Erweiterung der Indikations- und beruflichen Indikationsempfehlung für die saisonale Influenza-Impfung

Impfung gegen	Kategorie	Indikation	Anmerkungen (Packungsbeilage/Fachinformation beachten)
Influenza	I	Personen,* die im privaten Umfeld häufigen, regelmäßigen und direkten Kontakt zu z. B. Schweinen, Geflügel sowie Wildvögeln (frei und gehalten) und Robben haben.	Jährliche Impfung im Herbst mit einem inaktivierten Influenza-Impfstoff mit aktueller von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlener Antigenkombination. Für Personen ≥ 60 Jahre werden inaktivierte Hochdosis- oder MF-59-adjuvantierte Influenza-Impfstoffe empfohlen.
	B	Personen* einschließlich Auszubildenden, Praktikantinnen und Praktikanten, Studierenden und ehrenamtlich Tätigen, die arbeitsbedingt einen häufigen, regelmäßigen und direkten Kontakt zu z. B. Schweinen, Geflügel, Wildvögeln (frei und gehalten) und Robben haben und tätig sind in z. B.: ▶ Nutztierhaltungen ▶ Zoos oder Tierparks ▶ Tierheimen oder Auffangstationen ▶ Tierarztpraxen ▶ Schlachthöfen	Jährliche Impfung im Herbst mit einem inaktivierten Influenza-Impfstoff mit aktueller von der WHO empfohlener Antigenkombination. Für Personen ≥ 60 Jahre werden inaktivierte Hochdosis- oder MF-59-adjuvantierte Influenza-Impfstoffe empfohlen.
* Eine Impfung mit saisonalen humanen Influenza-Impfstoffen erfolgt nicht zum Schutz vor Infektionen durch den Erreger der aviären oder porcinen Influenza, sie kann jedoch Doppelinfektionen mit den aktuell zirkulierenden saisonalen Influenza-Viren reduzieren. Es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um den Individualschutz des oder der Arbeitnehmenden/der betreffenden Person vor einer Infektion durch saisonale Influenza-Viren, sondern zusätzlich um den Bevölkerungsschutz.			

Mitteilung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut

Beschluss der STIKO zur Erweiterung der Indikations- und beruflichen Indikationsempfehlung für die saisonale Influenza-Impfung

Impfung gegen	Kategorie	Indikation	Anmerkungen (Packungsbeilage/Fachinformation beachten)
Influenza	I	Personen,* die im privaten Umfeld häufigen, regelmäßigen und direkten Kontakt zu z. B. Schweinen, Geflügel sowie Wildvögeln (frei und gehalten) und Robben haben.	Jährliche Impfung im Herbst mit einem inaktivierten Influenza-Impfstoff mit aktueller von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlener Antigenkombination. Für Personen ≥ 60 Jahre werden inaktivierte Hochdosis- oder MF-59-adjuvantierte Influenza-Impfstoffe empfohlen.
	B	Personen* einschließlich Auszubildenden, Praktikantinnen und Praktikanten, Studierenden und ehrenamtlich Tätigen, die arbeitsbedingt einen häufigen, regelmäßigen und direkten Kontakt zu z. B. Schweinen, Geflügel, Wildvögeln (frei und gehalten) und Robben haben und tätig sind in z. B.: ▶ Nutztierhaltungen ▶ Zoos oder Tierparks ▶ Tierheimen oder Auffangstationen ▶ Tierarztpraxen ▶ Schlachthöfen	Jährliche Impfung im Herbst mit einem inaktivierten Influenza-Impfstoff mit aktueller von der WHO empfohlener Antigenkombination. Für Personen ≥ 60 Jahre werden inaktivierte Hochdosis- oder MF-59-adjuvantierte Influenza-Impfstoffe empfohlen.
* Eine Impfung mit saisonalen humanen Influenza-Impfstoffen erfolgt nicht zum Schutz vor Infektionen durch den Erreger der aviären oder porcinen Influenza, sie kann jedoch Doppelinfektionen mit den aktuell zirkulierenden saisonalen Influenza-Viren reduzieren. Es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um den Individualschutz des oder der Arbeitnehmenden/der betreffenden Person vor einer Infektion durch saisonale Influenza-Viren, sondern zusätzlich um den Bevölkerungsschutz.			

Inhalt

Herausforderungen im Ausbruchsmanagement – am Beispiel eines großen Influenza-Ausbruchs in einer Pflegeeinrichtung 4

Influenza-Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen sind aufgrund des hohen Alters sowie der häufig bestehenden Grunderkrankungen der Bewohnenden mit einem erheblichen Risiko für schwere Krankheitsverläufe und einem erhöhten Mortalitätsrisiko verbunden. In diesem Beitrag werden der Verlauf und das Management eines Influenza-Ausbruchs in einer Pflegeeinrichtung in Baden-Württemberg im Januar 2026 dargestellt. Im Rahmen des Ausbruchs erkrankten 54 Personen (47 Bewohnende, 7 Beschäftigte) und 7 Personen davon verstarben infolge der Influenza-Erkrankung (6 Bewohnende, 1 Pflegekraft). Trotz bereits eingeleiteter Maßnahmen durch die Einrichtung breitete sich das Infektionsgeschehen über einen Zeitraum von etwa drei Wochen aus. Auffällig waren die verzögerte Information des Gesundheitsamtes und das Fehlen einer antiviralen Postexpositionsprophylaxe. Anhand dieses Ausbruchs wird die Bedeutung einer frühen Meldung von Ausbrüchen, einer raschen Erregerdiagnostik, hoher Influenza-Impfquoten, der konsequenten Umsetzung von infektionshygienischen Maßnahmen, antiviraler Prophylaxe sowie der Vermeidung von *Staff Presenteeism* hervorgehoben.



Europäische Region meldet höchste Zahl von Masernfällen seit mehr als 25 Jahren – UNICEF, WHO/Europa

13 March 2025 | Media release | Reading time: 3 min (725 words)

Europäische Region verzeichnet 127 350
Masernfälle für das Jahr 2024 – doppelt so
viele wie für 2023 und die höchste Zahl seit
1997

www.who.int/europe/de/news/

STIKO-Empfehlungen seit 2010

Masernimpfung für Erwachsene



Die Masern-Impfung (in Form einer einmaligen MMR-Impfung) **wird für alle nach 1970 geborenen** Erwachsenen empfohlen, sofern sie nicht oder in der Kindheit nur einmal geimpft sind oder der Impfstatus unklar ist.

Die MMR-Impfung ist in Berlin* auch für vor 1971 Geborene öffentlich empfohlen!

* https://www.berlin.de/sen/gesundheit/_assets/themen/gesundheitschutz-und-umwelt/infektionsschutz/rundschreiben_berliner_impfempfehlung_2022_.pdf

Fall: absehbare Immunsuppression

STIKO: *„bei absehbar progredientem Verlauf der Grundkrankheit sollte ... in einem Stadium mit wenig beeinträchtigter Funktion des Immunsystems geimpft werden.“*

Leichte bis mittlere Immunsuppression

Leichte bis mittlere Immunsuppression (Grad II)

- 1.) Kortison (Prednisolonequivalent): <20 mg/d
aber >2 Wochen; <2 Wochen aber >20 mg/d, Depotgabe
- 2.) HIV-Infektion mit CD4 200 – 499/ μ l
- 3.) Niedrig dosierte Immunsuppression: Methotrexat <0,4 mg/kg/KG;
Azathioprin <3 mg/kg/KG; 6-Mercaptopurin <1,5 mg/kg/KG
- 4.) Asplenie (Sichelzellanämie)
- 5.) Chronische Erkrankung der Niere
- 6.) Chronische Erkrankung der Leber
- 7.) Multiple Sklerose ohne Behandlung
- 8.) Diabetes mellitus mit schlechtem Allgemeinzustand und
fortgeschrittener Erkrankung
- 9.) Komplementdefekte

Fall: absehbare Immunsuppression

- **Standard**impfungen (Tdap-IPV, MMR)
- frühzeitige **Varizellenserologie**, ggf. 2x impfen
- **H. zoster**-Grundimmunisierung (≥ 18 J.)
- **Pneumokokken**impfung
- **MenACWY- + MenB**-Grundimmunisierung
- **Influenza-** und **COVID-19**-Impf. (≥ 6 Mon.)
- **Hep. B**-Grundim., jährl. AK-Kontrolle (Ziel >100 mIU/ml)
- **RSV**-Impfung (≥ 60 Jahre)

Fall – Fledermauskontakt

6-jähriges Mädchen, auf Spielplatz noch lebende Fledermaus auf Boden gefunden, Kratzwunde

- ***Sind postexpositionelle Maßnahmen bzgl. Tollwut notwendig?***
- ***Welche Quelle nutzen Sie für Ihre Entscheidung?***

Tabelle 10 | Indikationen für eine postexpositionelle Tollwut-Immunprophylaxe (Tollwut-PEP) bei Immungesunden

Grad der Exposition	Art der Exposition durch ein tollwutverdächtiges oder tollwütiges Wild- oder Haustier oder eine Fledermaus	Postexpositionelle Immunprophylaxe (Fachinformationen beachten)	
		Nicht oder nur unvollständig vorgeimpfte Personen	Vollständig grundimmunisierte Personen ^b
I	Berühren/Füttern von Tieren, Belecken der intakten Haut	Keine Impfung	Keine Impfung
II	Nicht blutende, oberflächliche Kratzer oder Hautabschürfungen, Lecken oder Knabbern an der nicht intakten Haut (bei Exposition durch Fledermäuse gilt Grad III, s. u.)	Tollwut-Impfserie ^a	Immunisierung mit 2 Impfstoffdosen im Abstand von 3 Tagen ^b
III	Bissverletzungen oder Kratzwunden, Kontakt von Schleimhäuten oder Wunden mit Speichel (z. B. durch Lecken), Verdacht auf Biss oder Kratzer durch eine Fledermaus oder Kontakt der Schleimhäute mit einer Fledermaus	Tollwut-Impfserie, ^a simultan Verabreichung von Tollwut-Immunglobulin (20 IE/kg Körpergewicht)	Immunisierung mit 2 Impfstoffdosen im Abstand von 3 Tagen ^b

a Für die Immunisierung stehen in Deutschland 2 Impfstoffe zur Verfügung: Rabipur und Verorab. Die Tollwut-PEP kann laut Fachinformationen bei nicht oder nur unvollständig vorgeimpften Personen nach folgenden Schemata durchgeführt werden:

Essen-Schema: je 1 Impfstoffdosis an den Tagen 0, 3, 7, 14 und 28

Verkürztes Essen-Schema (nur für Rabipur bei gesunden, immunkompetenten Personen zugelassen): je 1 Impfstoffdosis an den Tagen 0, 3, 7, 14; nur bei Expositionsgrad II: Die Impfung ohne zusätzliche Gabe von Immunglobulinen orientiert sich an den Empfehlungen der WHO und stellt eine Abweichung von der Fachinformation von Rabipur dar.

Zagreb-Schema (nur bei Immunkompetenz): 2 Impfstoffdosen am Tag 0 (zeitgleich), je eine weitere Impfstoffdosis an den Tagen 7 und 21 (0, 0, 7, 21)

b Daten für Verorab und den bisher eingesetzten Tollwut-Impfstoff (HDC) inaktiviert haben gezeigt, dass ein Jahr nach Anwendung eines aus 2 Impfstoffdosen bestehenden PrEP-Schemas eine Boosterfähigkeit durch 2 Impfstoffdosen besteht. Daher ist bei einer Exposition innerhalb des ersten Jahres eine PEP mit 2 Impfstoffdosen am Tag 0 und Tag 3 ausreichend. Bei Personen mit einer PrEP mit 2 Dosen Tollwut-Impfstoff sollte eine 3. Impfstoffdosis spätestens nach einem Jahr verabreicht werden, wenn eine weitergehende Exposition besteht. Wenn diese 3. Impfstoffdosis nicht gegeben wurde, gibt es derzeit keine Daten für eine Boosterfähigkeit mit 2 Impfstoffdosen im Falle einer Exposition und notwendiger PEP. Bei einer Indikation zur PEP ist eine Gabe von Immunglobulinen nicht erforderlich, wenn als PrEP 2 oder mehr Impfstoffdosen verabreicht worden waren.

geändert am
4. Februar 2026



AKTUELLE DATEN UND INFORMATIONEN
ZU INFektionsKRANKHEITEN UND PUBLIC HEALTH

14
2025

3. April 2025

Epidemiologisches Bulletin

Empfehlungen der
Ständigen Impfkommission (STIKO)
und der Deutschen Gesellschaft für
Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale
Gesundheit e.V. (DTG) zu Reiseimpfungen

Inhalt STIKO- und DTG-Empfehlungen zu Reiseimpfungen

Abkürzungsverzeichnis	6	4 Übersicht zu den von der STIKO empfohlenen Impfungen aufgrund von Reisen	34
1 Einleitung	8	5 Anmerkungen zu einzelnen Impfungen	36
2 Allgemeine Aspekte bei der reisemedizinischen Beratung	9	5.1 Cholera	36
2.1 Risikofaktoren für reisessoziierte Erkrankungen	9	5.2 COVID-19	40
2.2 Aspekte zur individuellen Risiko-Nutzen-Bewertung von Impfungen	9	5.3 Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und verwandte Virusenzephalitiden (TBE, tick-borne encephalitis)	42
2.3 Vorgehen bei der individuellen Risiko-Nutzen-Bewertung	11	5.4 Gelbfieber	46
2.4 Empfohlene Standard- und Indikationsimpfungen	12	5.5 Hepatitis A	52
2.5 Nachweispflicht	13	5.6 Hepatitis B	56
2.6 Impfungen, die in der Reiseimpfsprechstunde keine Anwendung finden	14	5.7 Influenza (saisonal)	60
2.7 Wirksamkeit und Sicherheit von Impfungen	16	5.8 Japanische Enzephalitis	64
2.8 Last-Minute-Impfung (Hepatitis A) und Schnellimpfschemata	17	5.9 Meningokokken-Erkrankung	68
2.9 Zeitlicher Ablauf der Impfungen und Ko-Administration von Impfstoffen	17	5.10 Poliomyelitis	73
2.10 Zusätzliche Präventionsmaßnahmen	18	5.11 Tollwut	78
2.11 Reiseapotheke	19	5.12 Typhus/Paratyphus	84
2.12 Kostenerstattung von Reiseimpfungen	19	6 Ländertabelle	97
3 Impfungen bei besonderen Risikogruppen	20	7 Referenzen	
3.1 Schwangere und Stillende	20		
3.2 Säuglinge und Kleinkinder	21		
3.3 Ältere Reisende	22		
3.4 Reisende mit Grunderkrankungen	23		
3.4.1 Hinweise zu Grunderkrankungen ohne Immundefizienz	23		
3.4.1.1 Allgemeine Gesichtspunkte zu Grunderkrankungen ohne Immundefizienz	23		
3.4.1.2 Besonderheiten bei Blutgerinnungsstörungen/Behandlung mit Antikoagulantien	24		
3.4.2 Hinweise zu Grunderkrankungen mit Immundefizienz	24		
3.4.2.1 Allgemeine Gesichtspunkte zu Grunderkrankungen mit Immundefizienz	24		
3.4.2.2 Spezifische Gesichtspunkte zu einzelnen Reiseimpfungen bei Immundefizienz	26		
3.4.2.3 Spezifische Gesichtspunkte zu einzelnen Erkrankungsgruppen bei Immundefizienz	27		
a) Angeborene Immundefekte	27		
b) Infektion mit HIV (erworbener Immundefekt)	27		
c) Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) mit immunsuppressiver Therapie	27		
d) Chronische Nierenerkrankungen (terminale Niereninsuffizienz, Dialysepflichtigkeit)	28		
e) Asplenie/Hyposplenie	28		
f) Entzündlich-rheumatische Erkrankungen	29		
g) Neurologische Erkrankungen	29		
h) Hämatologische und onkologische Erkrankungen	30		
i) Zustand nach Organ- und Stammzelltransplantation	30		
3.5 MigrantInnen, die FreundInnen oder Verwandte im Ausland besuchen (Visiting Friends and Relatives, VFR)	31		
3.6 Langzeitaufenthalt	31		
3.7 KatastrophenhelferInnen	32		

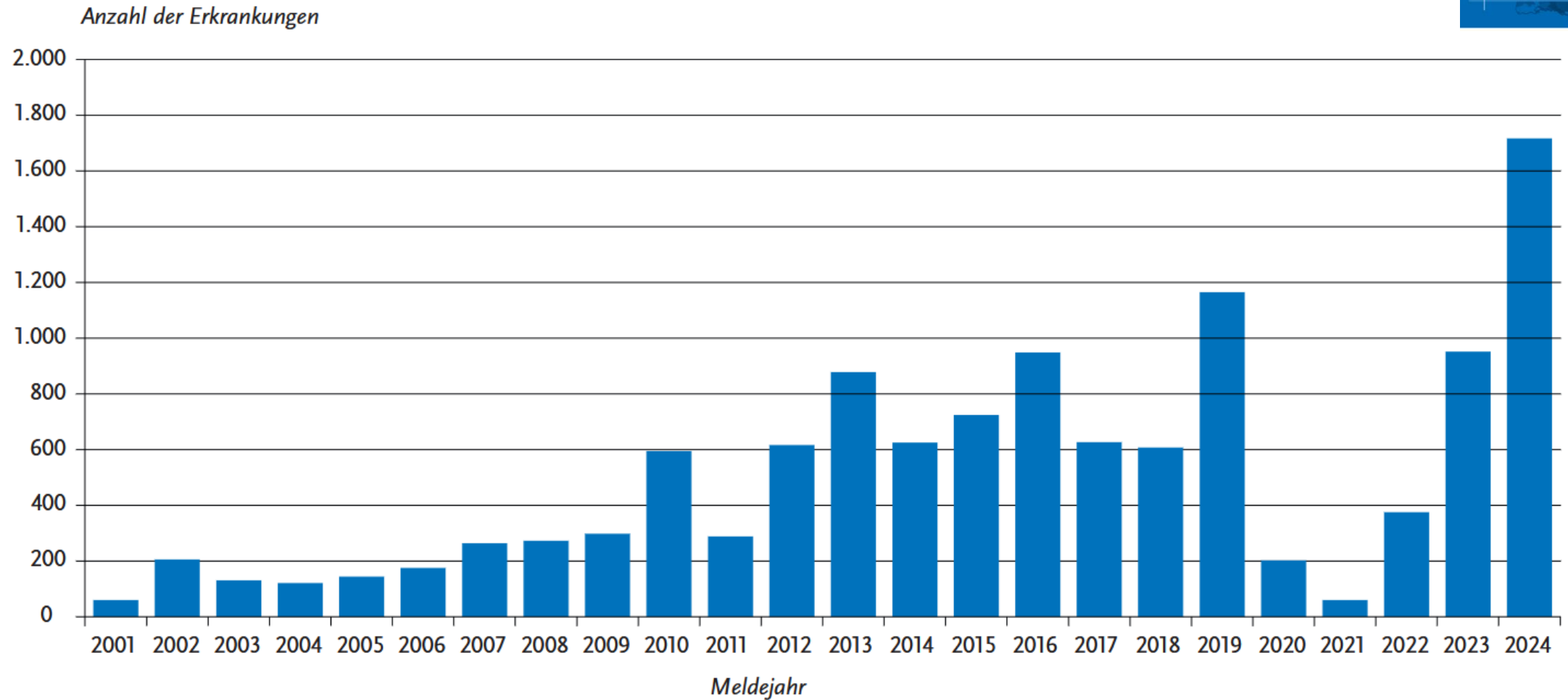
Hepatitis A-Impfung bei Reisen mit Immundefizienz

- bei Gabe der 1. monovalenten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung **zusätzliche monovalente Impfstoffdosis vor Abreise** empfohlen
- 2 Dosen **gleicher Tag oder Abstand 1 Mo.** (off-label)
- zur Vervollständigung der Grundimmunisierung **3. Dosis im Mindestabstand von 6 Monaten**

Anstieg importierter Denguefieber-Fälle

Jahr 2024: 1.717 gemeldete Infektionen (RKI).
Tropenmed. Ambulanz Berlin: 187 Fälle

Abb. 6.14.1:
Übermittelte Denguefieber-Erkrankungen nach Meldejahr, Deutschland, 2001 bis 2024



Dengue STIKO Empfehlung (Bulletin 48/2023)

Impfung gegen	Kategorie	Indikation	Anmerkungen (Packungsbeilage/Fachinformation beachten)
Dengue	R	Personen ≥ 4 Jahre, die anamnestisch eine labordiagnostisch gesicherte Dengue-Virusinfektion durchgemacht haben und in ein Dengue-Endemiegebiet reisen und dort ein erhöhtes Expositionsrisiko haben (z. B. längerer Aufenthalt, aktuelles Ausbruchsgeschehen). Für Personen, die in der Vergangenheit keine Dengue-Virusinfektion durchgemacht haben („Dengue-Naive“), spricht die STIKO aufgrund der gegenwärtig limitierten Datenlage derzeit keine allgemeine Impfeempfehlung aus (s. auch STIKO-Hinweise im Kasten auf S. 7). Weitere Hinweise s. Epid Bull 48/2023.⁶	Grundimmunisierung mit 2 Impfstoffdosen des tetravalenten attenuierten Lebendimpfstoffs Qdenga (Mindestabstand 3 Monate zwischen den Impfstoffdosen). Die vollständige Impfsreihe (2 Impfstoffdosen) sollte vor Abreise abgeschlossen sein (Endemiegebiete s. auch https://www.cdc.gov/dengue/areaswithrisk/around-the-world.html). Auffrischimpfungen: Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Aussage über die Notwendigkeit bzw. den Zeitpunkt einer Auffrischimpfung getroffen werden. Entsprechende Studien sind noch nicht abgeschlossen.
	B	Personen, die anamnestisch eine labordiagnostisch gesicherte Dengue-Virusinfektion durchgemacht haben und außerhalb von Endemiegebieten gezielte Tätigkeiten mit Dengue-Viren ausüben (z. B. in Forschungseinrichtungen oder Laboratorien).	

Dengue STIKO Empfehlung (Bulletin 48/2023)

Alter ≥ 4 J.

UND

Endemiegebiet mit erhöhtem Expositionsrisiko

UND

**Anamnestisch eine labordiagnostisch
bestätigte Dengue-Infektion durchgemacht**

B

Personen, die anamnestisch eine labordiagnostisch
gesicherte Dengue-Virusinfektion durchgemacht haben

**Die vollständige Impfserie (2 Impfdosen) sollte vor
Abreise abgeschlossen sein**

Dengue STIKO Empfehlung (Bulletin 48/2023)

Impfung gegen	Kategorie	Indikation	Anmerkungen (Packungsbeilage/Fachinformation beachten)
Dengue	R	Personen ≥ 4 Jahre, die anamnestisch eine labordiagnostisch gesicherte Dengue-Virusinfektion durchgemacht haben und in ein Dengue-Endemiegebiet reisen und dort ein erhöhtes Expositionsrisiko haben (z. B. längerer	Grundimmunisierung mit 2 Impfstoffdosen des tetravalenten attenuierten Lebendimpfstoffs Qdenga (Mindestabstand 3 Monate zwischen den Impfstoffdosen).

Falls keine Dengueinfektion durchgemacht:

„...die zu impfende Person dahingehend aufklären, dass das Risiko einer Infektionsverstärkung bei nachfolgender Infektion nicht ausgeschlossen werden kann.“

		mit Dengue-viren ausuben (z. B. in Forschungseinrichtungen oder Laboratorien).	

Anaphylaxie-Risiko nach Dengue-Impfung

2025, 100, 75-86

No 10



Weekly epidemiological record
Relevé épidémiologique hebdomadaire

7 MARCH 2025, 100th YEAR / 7 MARS 2025, 100^e ANNÉE

No 10, 2025, 100, 75-86
<http://www.who.int/wer>

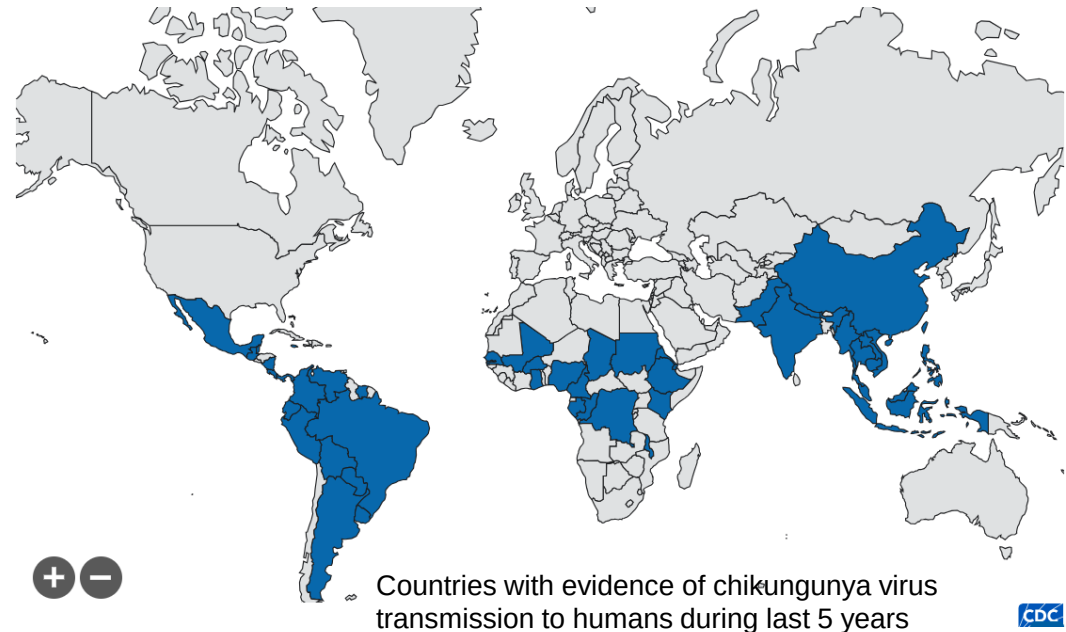
- 03/2023 – 09/2024
- Verabreichung von 2.878.801 Dosen in Brasilien
- 501 allergische Reaktionen
- 124 anaphylaktische Reaktionen (117 nach 1. Impfung)
- im Median nach 25 Min. (3-360 Min.)

WHO Empfehlung:

- Aufklärung bzgl. mögliche allergische Reaktion (Training für Impfende im Management)
- Überwachungszeit sollte ausgeweitet werden

Chikungunya

- Seit 2000er Jahre deutliche Zunahme an Ausbrüchen und Verbreitung
- Gegenwärtig >110 Länder in Asien, Afrika, Americas, Europa
- Jahr 2024: 21 Fälle Tropenmed. Ambulanz Charité Berlin
- Kurze IKZ 4 - 8d (2-12d)
- Fieber, Exanthem, Arthralgien, Chronifizierung (in 30-40 %)



Robert Koch-Institut. Infektionsepidemiologisches Jahrbuch meldepflichtiger Krankheiten für 2022, Berlin 2024

https://www.cdc.gov/chikungunya/data-maps/?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/chikungunya/geo/index.html; Stand 29.04.2025

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chikungunya>

Chikungunya-Impfstoffe



- **Lebendimpfstoff**
- i.m.- Einmalgabe
- Zulassung ab 12 Jahren
- SPR: 98,9 % (Tag 29)
- SPR: 96,8 % (nach 2 Jahren)
- Arthralgien (18% vs 6,1%),
Kopfschmerzen (32% vs 15,5%),
Myalgien (24,3% vs 7,9%)



- **Totimpfstoff (VLP-Impfstoff)**
- i.m.- Einmalgabe
- Zulassung ab 12 Jahren
- SPR: 96,8% (d15)
- SPR: 85.5 % (d183)
- Schmerzen lokal (24%),
Fatigue (17,8%), Cephalgie
(16,7%), Myalgie (16,5%)

<https://www.bavarian-nordic.com/media/363118/vimkunya1.png>

<https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2025/04/04/erster-impfstoff-gegen-chikungunya-fieber-neues-praeparat-ixchIQ-koennte-nicht>

Safety and immunogenicity of a single-shot live-attenuated chikungunya vaccine: a double-blind, multicentre, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial; Schneider, Martina et al.; The Lancet, Volume 401, Issue 10394, 2138 – 2147
Antibody persistence and safety of a live-attenuated chikungunya virus vaccine up to 2 years after single-dose administration in adults in the USA: a single-arm, multicentre, phase 3b study; McMahon, Robert et al.; The Lancet Infectious Diseases, Volume 24, Issue 12, 1383 – 1392;

Chikungunya STIKO Empfehlung 07/2025

Impfung gegen	Kategorie	Indikation	Anmerkungen (Packungsbeilage/Fachinformation beachten)
Chikungunya	R	Personen ≥ 12 Jahre, ▶ die in ein Gebiet reisen, für das ein aktuelles Chikungunya-Ausbruchsgeschehen bekannt ist, ▶ die einen längeren Aufenthalt (> 4 Wochen) oder wiederholte Kurzaufenthalte in Chikungunya-Endemiegebieten planen und bei denen ein erhöhtes Risiko für eine Chronifizierung oder einen schweren Verlauf der Erkrankung besteht (z. B. Alter ≥ 60 Jahre oder eine schwere internistische Grunderkrankung).	Eine Impfstoffdosis des attenuierten Lebendimpfstoffs oder des Totimpfstoffs. Für Personen ≥ 60 Jahre soll nur der Totimpfstoff verwendet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Aussage über die Notwendigkeit bzw. den Zeitpunkt einer Auffrischung getroffen werden. Weitere Hinweise, u. a. zu den Kontraindikationen und Impfstoffprofilen sowie zu den beruflich Reisenden (z. B. Militär), s. Wissenschaftliche Begründung zur Impfung gegen Chikungunya sowie Reiseimpfempfehlungen der STIKO und der DTG.
	B	Personen, die gezielte Tätigkeiten mit Chikungunya-Viren gemäß Biostoffverordnung ausüben (z. B. in Forschungseinrichtungen oder Laboratorien) unter Berücksichtigung der Altersgruppen für die jeweiligen Impfstoffe.	

Auszug aus Tabelle 2 | Empfehlungen zu Standardimpfungen des Erwachsenenalters sowie zu Indikations- (Berufs- und Reiseimpfungen) und Auffrischimpfungen für alle Altersgruppen

Current outbreaks

There is a [chikungunya travel health notice](#) for outbreaks

- Bolivia (Santa Cruz and Cochabamba Departments)
- Cuba
- Mayotte
- Seychelles
- Suriname

Chikungunya presence

- Not detected
- Detected
- Not applicable

Chikungunya Lebendimpfstoff – US FDA

Today 8/22/2025 the US FDA's Center for Biologics Evaluation and Research has **suspended** the biologics **license** for Valneva Austria GmbH's live-attenuated **IXCHIQ** vaccine. This vaccine was initially approved by the FDA under the accelerated approval pathway in November of 2023 for the prevention of disease caused by the chikungunya virus (CHIKV) in individuals 18 years of age and older who are at increased risk of exposure to CHIKV. CBER's decision is based on **serious safety concerns** related to the vaccine, which appears to be causing **chikungunya-like illness** in vaccine recipients. There has been **one death from encephalitis** directly attributable to the vaccine (CSF PCR was + for the vaccine strain of the virus) and over **20 reported serious adverse events** that were consistent with chikungunya-like illness. Reported serious adverse events have included **21 hospitalizations and 3 deaths**. Furthermore, the clinical benefit of the vaccine has not yet been verified in confirmatory clinical studies. CBER's benefit-risk analysis broadly shows the vaccine does not have benefits outweighing risks, under most plausible scenarios. For these reasons, CBER believes this vaccine is not safe and that continued administration to the public would pose a danger to health.





Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 9 - 12 March 2026



13 March 2026

PRAC warns about known risk of aseptic meningitis with chikungunya vaccine Ixchiq

News

Human

Pharmacovigilance

Page contents

[Agenda](#)

PRAC warns about known risk of aseptic meningitis with chikungunya vaccine Ixchiq

Update to product information recommended to reflect recent evidence





Sprechstunde Tropenmedizinische Ambulanz

Öffnungszeiten: Mo - Fr.: 08:00 - 13:00 (Terminsprechstunde)

Blutentnahmen in der Regel nur bis 12:00 möglich. Bitte beachten Sie, dass eine medizinische Beratung per Email nicht möglich ist.

Interne Geländeadresse: [Südring 2, Erdgeschoss](#) 



Ambulanz Faxnummer: +49 30 450 565 930



[Kontakt aufnehmen](#) 



Informationen zur Vorstellung / Terminvereinbarung (bitte die verschiedenen Kategorien beachten)

1. Akute Beschwerden

Wir haben eine offene Sprechstunde (ohne Voranmeldung) für Patient*innen mit akuten Beschwerden (z.B. Fieber, blutiger Durchfall): Mo – Fr 8:00 – 13:00 Uhr. Vor Ort erfolgt eine Ersteinschätzung und Sie werden entweder direkt versorgt oder erhalten einen Termin. Bitte stellen Sie sich möglichst vor 11 Uhr vor. Planen Sie bitte längere Wartezeiten ein. Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht bei Notfällen (wie z.B. Fieber nach Aufenthalt in einem Malariagebiet) die Rettungsstelle zur Verfügung.